Estilo UERJ

Simulado 10 Resolução

Gabarito, a armadilha de cada questão, o dado que decide e o raciocínio completo, alternativa por alternativa.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE CORRIGIR

Como usar esta resolução

Corrija olhando primeiro a coluna da arma. O que interessa não é o total de acertos, é em qual armadilha você caiu.

ARMA DA BANCA	O QUE FAZ	QUESTÕES	ONDE ESTÃO
Rótulo verdadeiro	um dado real do paciente puxa para a doença de manual errada	11	2, 4, 5, 10, 12, 17, 30, 38, 39, 41, 43
Negativo no meio	o discriminante é um dado negativo no meio do caso	4	6, 21, 25, 44
Dado omitido	o achado mais famoso foi retirado	2	14, 49
Droga a deduzir	a droga em uso não é nomeada	5	1, 22, 23, 27, 48
Grade X / Y	alternativa composta em que uma metade não basta	10	3, 8, 16, 18, 19, 33, 34, 37, 45, 47
Qualificador	o comando restringe o que se pede	4	15, 31, 35, 50
Limiar	um ponto de corte ou janela decide	6	7, 11, 13, 32, 36, 40
Omissão	a resposta certa é não fazer, ou o degrau mais simples	4	24, 26, 28, 29
Cronologia	o tempo entre os eventos decide	4	9, 20, 42, 46

O que cada arma treina em você

- **Rótulo verdadeiro, negativo no meio, dado omitido:** a leitura em modo confirmação, a sua maior causa de erro de identificação.
- **Grade X / Y e qualificador:** a alternativa aceita pela metade e o comando lido pela metade.
- **Limiar, cronologia e omissão:** a regra aplicada sem checar a condição que a habilita, e o exame ou tratamento a mais, o seu padrão dominante em 15/10/2026.
- **Droga a deduzir:** a droga em uso que decide e não vem nomeada.

Todas as questões têm uma única alternativa defensável pela diretriz citada. Se discordar de alguma, anote: discutir o gabarito é o melhor treino.

GABARITO

Respostas

1 **C**	2 **D**	3 **D**	4 **B**	5 **D**	6 **A**	7 **C**	8 **C**	9 **D**	10 **D**
11 **C**	12 **C**	13 **C**	14 **A**	15 **B**	16 **B**	17 **B**	18 **B**	19 **B**	20 **B**
21 **D**	22 **C**	23 **C**	24 **C**	25 **B**	26 **B**	27 **A**	28 **D**	29 **B**	30 **A**
31 **D**	32 **A**	33 **A**	34 **D**	35 **A**	36 **A**	37 **A**	38 **C**	39 **B**	40 **B**
41 **A**	42 **D**	43 **A**	44 **D**	45 **C**	46 **A**	47 **B**	48 **A**	49 **D**	50 **C**

A cor ao lado de cada letra é a da arma da banca, como na tabela anterior. Distribuição: A 13, B 13, C 12, D 12.

RESOLUÇÃO

Questão por questão

1 Infectologia · Linezolida com escitalopram e tramadol: síndrome serotoninérgica confundida com síndrome neuroléptica maligna após haloperidol

Droga a deduzir **Gabarito C**

Homem de 66 anos, internado há 6 dias por pneumonia necrotizante por Staphylococcus aureus resistente à meticilina, recebe linezolida 600 mg de 12/12 horas desde o 3º dia, após lesão renal com vancomicina. Usa em casa escitalopram 20 mg/dia e tramadol para lombalgia, mantidos na internação. Ontem à noite ficou agitado e recebeu haloperidol 5 mg IV. Hoje está confuso, com T 39,2 °C, FC 124 bpm, PA 168 × 96 mmHg, sudorese profusa, midríase, diarreia, tremor, hiper-reflexia e clônus induzível nos membros inferiores, mais intensos que nos superiores. CK 620 U/L. Hemoculturas recentes negativas. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

hiper-reflexia e clônus induzível nos membros inferiores

Resolução. Febre, rigidez possível, disautonomia e CK alta logo após haloperidol levam à síndrome neuroléptica maligna. A droga que explica o quadro, porém, é outra: a linezolida é inibidor fraco e reversível da monoaminoxidase, e somada a escitalopram e tramadol (que também é serotoninérgico) desencadeia síndrome serotoninérgica. O que separa as duas está no exame neurológico e no tempo: a serotoninérgica começa em horas, com hiper-reflexia e clônus (predominando nos membros inferiores), midríase, diarreia e tremor; a neuroléptica maligna evolui em dias, com rigidez em cano de chumbo, bradirreflexia e CK muito mais alta. A conduta é suspender os serotoninérgicos (trocando a linezolida por outro agente ativo contra MRSA pulmonar), suporte, benzodiazepínico e, se necessário, ciproeptadina; o haloperidol deve ser evitado.

A) Sepse por nova infecção hospitalar
Errada. Sepse explicaria febre e taquicardia, mas não clônus, midríase e hiper-reflexia, e as hemoculturas são negativas.

B) Síndrome neuroléptica maligna ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o haloperidol é real, mas a neuroléptica maligna dá rigidez e hiporreflexia, sem clônus, e evolui em dias.

C) Síndrome serotoninérgica CORRETA
Correta. Linezolida (inibidor de MAO) com escitalopram e tramadol, e clônus com hiper-reflexia: síndrome serotoninérgica.

D) Acidose láctica pela linezolida
Errada. Acidose láctica pela linezolida surge em uso prolongado e causa taquipneia e náuseas, não clônus e hipertermia.

Para levar. Linezolida é inibidor de MAO: com ISRS ou tramadol pode causar síndrome serotoninérgica, que se separa da neuroléptica maligna pelo clônus e hiper-reflexia.

Boyer EW, Shannon M. The serotonin syndrome. N Engl J Med 2005; bula da linezolida (FDA, alerta de interação com serotoninérgicos, 2011); Hunter Serotonin Toxicity Criteria (Dunkley et al., 2003).

2

Cardiologia · Constrição pericárdica pós-revascularização com túnel do carpo: o eco separa da amiloidose

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 74 anos, operado de revascularização miocárdica há 5 anos e de túnel do carpo bilateral há 3 anos, tem edema de membros inferiores, aumento do volume abdominal e cansaço há 8 meses. Exame: PA 112×70 mmHg, FC 88 bpm, ritmo regular, turgência jugular que aumenta na inspiração, descenso y profundo, ruído protodiastólico curto e seco no ápice, ascite, sem sopros. ECG: ritmo sinusal, QRS de voltagem normal e alterações inespecíficas da onda T. Ecocardiograma: paredes de 10 mm, fração de ejeção de 58%, átrios moderadamente aumentados, movimento septal anômalo que se acentua na inspiração, variação respiratória do fluxo mitral de 32%, e' septal de 13 cm/s, maior que o e' lateral de 9 cm/s, e veias hepáticas com reversão diastólica na expiração. NT-proBNP de 260 pg/mL. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

e' septal de 13 cm/s, maior que o e' lateral de 9 cm/s

Resolução. Idoso com túnel do carpo bilateral, insuficiência cardíaca direita e fisiologia de enchimento restrito é o roteiro da amiloidose por transtirretina, e esse rótulo verdadeiro é a armadilha. Constrição e restrição têm a mesma clínica (Kussmaul, descenso y profundo, ascite, átrios grandes), e o que as separa está no ecocardiograma. Na restrição o miocárdio é doente: e' baixo (abaixo de cerca de 8 cm/s), paredes espessas na amiloidose, pouca variação respiratória e BNP muito alto. Na constrição o miocárdio é normal e a carapaça pericárdica é que limita: e' septal preservado ou aumentado e MAIOR que o lateral (o 'annulus reversus', porque a parede lateral é a presa ao pericárdio), salto septal que piora na inspiração, variação respiratória do fluxo mitral acima de 25%, reversão diastólica nas hepáticas na expiração e BNP relativamente baixo. O ruído protodiastólico seco é o knock pericárdico. A cirurgia cardíaca prévia é hoje uma das causas mais comuns de constrição.

A) Amiloidose cardíaca por transtirretina ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a resposta com paredes espessas, e' baixo, pouca variação respiratória, QRS de baixa voltagem e BNP alto; aqui as paredes medem 10 mm, o e' septal é alto e o BNP é baixo.

B) Cardiomiopatia restritiva idiopática
Errada. A restritiva também tem e' baixo e BNP alto, e não tem salto septal nem variação respiratória marcada.

C) Cardiomiopatia isquêmica com disfunção diastólica
Errada. A fração de ejeção é normal, o e' é preservado, e a interdependência ventricular com a respiração não é da disfunção diastólica isquêmica.

D) Pericardite constritiva CORRETA
Correta. Annulus reversus (e' septal maior que o lateral), salto septal respiratório, variação mitral acima de 25%, knock e BNP baixo após cirurgia cardíaca são constrição.

Para levar. Constrição x restrição: constrição tem e' septal normal ou alto e maior que o lateral, salto septal respiratório, variação mitral acima de 25% e BNP baixo; restrição tem e' baixo e BNP alto.

ESC 2025 (myocarditis and pericarditis); ASE/EACVI 2016 e Mayo Clinic Criteria (Welch TD et al., Circ Cardiovasc Imaging 2014)

3

Grade X / Y **Gabarito D**

Endocrinologia · Hipoglicemia no etilista em jejum que não responde ao glucagon: bloqueio da gliconeogênese com glicogênio esgotado, tiamina e glicose venosa

Homem de 52 anos, etilista pesado, é encontrado sonolento em casa após 3 dias de consumo intenso de cachaça com quase nenhuma ingestão alimentar. Não tem diabetes e não usa medicações. O socorrista mediu glicemia capilar de 34 mg/dL e aplicou glucagon 1 mg por via intramuscular; 20 minutos depois, a glicemia era de 36 mg/dL e o paciente continuava sonolento. Na emergência: FC 108 bpm, PA 104 × 66 mmHg, pupilas isocóricas, sem sinais focais, hálito etílico. Gasometria com acidose metabólica de ânion gap aumentado, lactato 3,1 mmol/L, cetonas séricas positivas. O mecanismo da hipoglicemia e a conduta mais adequada são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

com quase nenhuma ingestão alimentar

Resolução. Depois de 2 a 3 dias de jejum, o glicogênio hepático está esgotado e a glicemia depende da gliconeogênese. O metabolismo do etanol consome NAD+ e eleva a relação NADH/NAD+, o que desvia piruvato para lactato e oxaloacetato para malato e bloqueia a gliconeogênese; daí hipoglicemia com lactato e cetoácidos altos. O álcool não estimula a secreção de insulina, que está suprimida. Quem acerta o mecanismo pode ainda tropeçar na conduta: o glucagon age liberando glicogênio, e por isso não funciona sem estoque, como o próprio caso mostra (glicemia de 34 para 36 após 20 minutos). A conduta é glicose venosa, com tiamina administrada junto ou antes, sem atrasar a glicose, porque o etilista desnutrido tem risco de encefalopatia de Wernicke ao receber carga de glicose.

A) Hiperinsulinismo induzido pelo álcool / repetir o glucagon
Errada. O álcool não causa hiperinsulinismo, e repetir o glucagon falha de novo sem glicogênio.

B) Hiperinsulinismo induzido pelo álcool / tiamina e glicose EV
Errada. A conduta está certa, mas o mecanismo não: a insulina está suprimida; o defeito é a gliconeogênese bloqueada no jejum.

C) Gliconeogênese bloqueada, sem glicogênio / repetir o glucagon ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o mecanismo está certo, mas o glucagon depende de glicogênio, que o jejum de 3 dias esgotou, como mostrou a primeira dose.

D) Gliconeogênese bloqueada, sem glicogênio / tiamina e glicose EV CORRETA
Correta. Jejum prolongado com etanol: glicogênio esgotado e gliconeogênese bloqueada pelo excesso de NADH; trata-se com glicose venosa e tiamina.

Para levar. Hipoglicemia do etilista em jejum é falta de glicogênio com gliconeogênese bloqueada: glucagon não funciona; dê glicose venosa com tiamina.

Endocrine Society 2009 (Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders); Harrison's Principles of Internal Medicine, 21ª ed., 2022 (cap. Hypoglycemia).

4

Hematologia · Monocitose persistente em idoso com doença inflamatória tratada: leucemia mielomonocítica crônica, investigar com medula e citogenética

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 72 anos, com polimialgia reumática há 1 ano, controlada com prednisona 5 mg/dia, VHS 12 mm/h e PCR normal. Há 5 meses seus hemogramas mostram monocitose: hoje, leucócitos 15.400/mm³ com monócitos 2.900/mm³ (19%), neutrófilos 10.200/mm³ com alguns hipogranulares, sem blastos; Hb 11,2 g/dL, VCM 101 fL, plaquetas 108.000/mm³. Baço palpável a 3 cm do rebordo costal. Sem febre, sem perda de peso, sem sintomas respiratórios; radiografia de tórax, ecocardiograma e hemoculturas normais; IGRA negativo. B12 e folato normais. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Há 5 meses seus hemogramas mostram monocitose

Resolução. A polimialgia em corticoide é um rótulo verdadeiro: doença inflamatória e corticoide causam monocitose reativa, e o apressado repete o hemograma. Mas a monocitose é acima de 1.000/mm³ e acima de 10% dos leucócitos, persiste há mais de 3 meses, a doença inflamatória está controlada (VHS e PCR normais) e as causas infecciosas foram afastadas. Somam-se anemia macrocítica, plaquetopenia, neutrófilos hipogranulares (displasia) e esplenomegalia. Isso preenche a suspeita de leucemia mielomonocítica crônica, neoplasia mielodisplásica/mieloproliferativa. O diagnóstico se faz com aspirado e biópsia de medula, com contagem de blastos e promonócitos, citogenética (e exclusão de BCR::ABL1) e, quando disponível, painel molecular (TET2, SRSF2, ASXL1). JAK2 é exame das neoplasias mieloproliferativas Filadélfia negativas, e PET-CT procura linfoma ou neoplasia sólida, sem pistas aqui.

A) Repetir hemograma em 3 meses ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria aceitável numa monocitose recente com doença inflamatória ativa; aqui ela persiste há 5 meses, com citopenias e displasia.

B) Mielograma e biópsia com citogenética CORRETA

Correta. Monocitose persistente acima de 1.000/mm³ e de 10%, com citopenias, displasia e baço: medula com citogenética para leucemia mielomonocítica crônica.

C) Pesquisa de JAK2 V617F

Errada. JAK2 V617F é o exame de policitemia vera, trombocitemia essencial e mielofibrose, que não se apresentam com monocitose e citopenias.

D) PET-CT de corpo inteiro

Errada. Seria um passo diante de suspeita de linfoma ou de neoplasia oculta, sem linfonodos nem sintomas B aqui.

Para levar. Monocitose acima de 1.000/mm³ e 10% por mais de 3 meses, sem causa reativa e com citopenia ou displasia, é leucemia mielomonocítica crônica até prova em contrário: medula com citogenética.

WHO Classification of Haematolymphoid Tumours, 5th edition (2022) e ICC 2022 (critérios de LMMC); Patnaik & Tefferi, CMML: 2024 update, Am J Hematol.

5 Pneumologia · Obstrução fixa após transplante alogênico de medula: bronquiolite obliterante, não asma reativada

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 36 anos, há 14 meses submetido a transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas por leucemia mieloide aguda, em remissão, tem dispneia progressiva aos esforços há 4 meses, sem febre. Teve doença do enxerto contra o hospedeiro em pele e boca, controlada com ciclosporina. Na infância teve bronquite, sem crises desde os 12 anos. Ausculta pulmonar normal, SpO2 95%. Espirometria: VEF1/CVF 0,58, VEF1 54% do previsto (era 98% antes do transplante), sem resposta ao broncodilatador. TC de tórax em inspiração normal; em expiração, aprisionamento aéreo em mosaico difuso. Lavado broncoalveolar sem infecção. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

sem resposta ao broncodilatador

Resolução. A história de bronquite na infância é verdadeira e convida a chamar a obstrução de asma. Mas a obstrução é nova (VEF1 caiu de 98% para 54%), fixa, sem resposta ao broncodilatador, a ausculta é normal e a TC só se altera em expiração, com aprisionamento aéreo em mosaico: lesão da pequena via aérea. Depois de transplante alogênico, com doença do enxerto contra o hospedeiro em outros órgãos, esse quadro é a bronquiolite obliterante, manifestação pulmonar da doença do enxerto crônica, e os critérios do NIH se cumprem com VEF1/CVF baixa, VEF1 abaixo de 75%, aprisionamento aéreo e ausência de infecção. O tratamento inicial inclui fluticasona inalatória, azitromicina e montelucaste (esquema FAM), além da imunossupressão sistêmica; o prognóstico é reservado.

A) Asma reativada pela imunossupressão ARMADILHA
Errada. Asma daria obstrução variável, com resposta ao broncodilatador e sibilos; a obstrução aqui é fixa e nova.

B) Pneumonia em organização
Errada. Pneumonia em organização dá consolidações e vidro fosco na inspiração, com padrão restritivo.

C) Toxicidade pulmonar da ciclosporina
Errada. Ciclosporina não causa lesão pulmonar relevante; seria lembrar de bleomicina, metotrexato ou amiodarona.

D) Bronquiolite obliterante CORRETA
Correta. Obstrução fixa nova com aprisionamento aéreo só na expiração após transplante alogênico com doença do enxerto: bronquiolite obliterante.

Para levar. Obstrução fixa nova após transplante alogênico, com TC normal em inspiração e mosaico na expiração, é bronquiolite obliterante (doença do enxerto pulmonar); tratar com FAM e imunossupressão.

Jagasia MH et al. NIH Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic GVHD: 2014 Diagnosis and Staging Working Group Report. Biol Blood Marrow Transplant 2015.

6 Reumatologia · Monoartrite de joelho em artrite reumatoide controlada com anti-TNF: artrocentese antes de infiltrar corticoide

Negativo no meio **Gabarito A**

Mulher de 57 anos, com artrite reumatoide há 12 anos, em uso de metotrexato 20 mg/semana, adalimumabe e prednisona 5 mg/dia, controlada há 1 ano (DAS28 de 2,4), refere há 3 dias dor intensa e edema no joelho direito, com dificuldade para deambular. Nega trauma. Tax 37,4 °C, PA 124 × 76 mmHg, FC 92 bpm. Joelho direito quente, com derrame volumoso e dor à mobilização passiva; punhos, metacarpofalângicas, interfalângicas e joelho esquerdo sem sinovite. Leucócitos 11.800/mm³, PCR 98 mg/L. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

punhos, metacarpofalângicas, interfalângicas e joelho esquerdo sem sinovite

Resolução. Em quem tem artrite reumatoide, uma articulação inflamada parece apenas uma crise da doença, e a infiltração de corticoide resolve a crise localizada. Mas a doença está controlada há 1 ano e só o joelho direito está acometido, com as demais articulações sem sinovite: monoartrite desproporcional numa AR quieta é artrite séptica até prova em contrário. Os fatores de risco se somam (AR com articulação danificada, anti-TNF, metotrexato e corticoide), e os imunossupressores atenuam a febre, o que explica a temperatura de 37,4 °C. A conduta é puncionar antes de qualquer droga, com celularidade, Gram, cultura e pesquisa de cristais, e iniciar antibiótico empírico após a coleta se o líquido for purulento; infiltrar corticoide numa articulação séptica é um erro grave.

A) Artrocentese diagnóstica antes de qualquer droga CORRETA

Correta. Monoartrite em AR controlada, sob anti-TNF, é séptica até prova em contrário: puncionar antes de tratar.

B) Infiltração intra-articular de corticoide ARMADILHA

Errada. Seria a conduta numa crise oligoarticular com infecção afastada pela punção; aqui pode semear uma artrite séptica.

C) Aumentar a prednisona para 20 mg/dia

Errada. Seria opção numa reativação poliarticular; com uma só articulação e infecção não afastada, mascara a sepse.

D) Trocar o adalimumabe por tocilizumabe

Errada. Troca de biológico é para falha poliarticular documentada, não para uma monoartrite aguda ainda sem diagnóstico.

Para levar. Monoartrite desproporcional em AR controlada, sobretudo sob biológico, é séptica até prova em contrário: artrocentese antes de corticoide.

EULAR recommendations for the management of RA (2022 update); BSR/BHPR/BOA guideline for management of the hot swollen joint in adults (Coakley et al., 2006).

7

Gastroenterologia · Esteatorreia persistente na pancreatite crônica em reposição enzimática: dose de lipase insuficiente

Limiar **Gabarito C**

Homem de 54 anos, com pancreatite crônica alcoólica (calcificações pancreáticas difusas), abstinente há 2 anos, com diabetes em insulina, mantém 4 evacuações volumosas, gordurosas e malcheirosas ao dia e perda de 3 kg em 4 meses. Foi orientado a tomar pancreatina em cápsulas de 10.000 U de lipase, uma cápsula no meio de cada uma das três refeições principais, e relata adesão completa. Usa omeprazol 20 mg/dia. Exames: elastase fecal de 35 mcg/g, albumina 3,6 g/dL, vitamina D 14 ng/mL, antitransglutaminase IgA negativo com IgA total normal. A causa mais provável da persistência da esteatorreia é:

O DADO QUE DECIDE

cápsulas de 10.000 U de lipase, uma cápsula

Resolução. Supercrescimento bacteriano é causa real de esteatorreia persistente na pancreatite crônica, e é a resposta de quem procura uma segunda doença. Mas o primeiro passo diante de falha é conferir a dose: a reposição recomendada começa com 40.000 a 50.000 U de lipase nas refeições principais (e metade nos lanches), tomadas durante a refeição. Uma cápsula de 10.000 U por refeição é um quarto a um quinto da dose mínima, e explica sozinha a esteatorreia, a perda de peso e a vitamina D baixa. A inativação pelo ácido seria a explicação com dose adequada, e ele já usa omeprazol, que é exatamente o passo para isso; a doença celíaca foi afastada com IgA normal. Só depois de dose otimizada e IBP é que se investiga supercrescimento.

A) Inativação das enzimas pelo ácido gástrico
Errada. A acidez inativa as enzimas e se trata com IBP, mas ele já usa omeprazol; o problema primário é a dose.

B) Doença celíaca associada
Errada. Associação possível, mas a antitransglutaminase é negativa com IgA total normal.

C) Dose de lipase insuficiente por refeição CORRETA
Correta. 10.000 U de lipase por refeição está muito abaixo dos 40.000 a 50.000 U recomendados.

D) Supercrescimento bacteriano do delgado ARMADILHA
Errada. Seria investigado se a esteatorreia persistisse com dose adequada e IBP; aqui a dose é um quarto do mínimo.

Para levar. Insuficiência pancreática exócrina: 40.000 a 50.000 U de lipase por refeição principal, durante a refeição; na falha, primeiro conferir dose e adesão, depois IBP, e só então outra causa.

ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis (2020); AGA Clinical Practice Update on the Epidemiology, Evaluation, and Management of Exocrine Pancreatic Insufficiency (2023); United European Gastroenterology Guideline (2017)

8

Nefrologia · Alcalemia no DPOC retentor ventilado com pCO2 normalizada · alcalose metabólica pós-hipercápnica e redução da ventilação-minuto

Grade X / Y **Gabarito C**

Homem de 72 anos, com DPOC grave e retenção crônica de CO2 (gasometria ambulatorial: pH 7,36, pCO2 62 mmHg, bicarbonato 34 mEq/L), foi intubado há 36 horas por exacerbação com pH 7,18 e pCO2 98 mmHg. Desde

então está em volume controlado com frequência de 24 irpm. Não recebeu diurético, não tem sonda gástrica aberta e não vomitou. Hoje apresenta extrassístoles ventriculares frequentes; a gasometria mostra pH 7,59, pCO2 39 mmHg e bicarbonato 36 mEq/L; potássio 3,6 mEq/L, cloro 96 mEq/L. Quanto ao distúrbio e à conduta inicial, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

pCO2 39 mmHg e bicarbonato 36 mEq/L

Resolução. Paciente no ventilador com alcalemia leva a pensar em alcalose respiratória, mas a pCO2 de 39 é normal: o distúrbio primário é o bicarbonato de 36, que o rim acumulou durante meses para compensar a hipercapnia crônica e que não cai em 36 horas quando a pCO2 é levada ao normal. É a alcalose metabólica pós-hipercápnica, e a ventilação que normaliza a pCO2 de um retentor crônico é a causa. A conduta inicial é corrigir a origem: reduzir a ventilação-minuto e aceitar a pCO2 próxima do basal dele (cerca de 55 a 60 mmHg), mirando o pH e não a pCO2. A acetazolamida, que aumenta a excreção de bicarbonato, é tentadora porque trata o número, mas é o degrau seguinte, se a alcalemia persistir após o ajuste ou se for preciso baixar o bicarbonato para o desmame, e também espolia potássio num paciente com extrassístoles e potássio de 3,6.

A) Alcalose respiratória aguda / reduzir a ventilação-minuto
Errada. A conduta está certa, mas a alcalose respiratória exigiria pCO2 abaixo de 35 mmHg; com 39, o primário é metabólico.

B) Alcalose respiratória aguda / acetazolamida
Errada. Erra as duas metades: a pCO2 é normal e a droga não é o primeiro passo.

C) Alcalose metabólica pós-hipercápnica / reduzir a ventilação-minuto CORRETA
Correta. pCO2 normal com bicarbonato alto num retentor ventilado: alcalose metabólica pós-hipercápnica, corrigida primeiro devolvendo a pCO2 ao basal.

D) Alcalose metabólica pós-hipercápnica / acetazolamida ARMADILHA
Errada. O diagnóstico está certo, mas a acetazolamida é adjuvante, depois de ajustar a ventilação; usá-la primeiro trata o número e espolia potássio.

Para levar. Retentor crônico de CO2 ventilado até pCO2 normal desenvolve alcalose metabólica pós-hipercápnica: reduzir a ventilação-minuto e mirar o pH com a pCO2 próxima do basal; acetazolamida é adjuvante.

GOLD 2025 Report (ventilação na exacerbação); Galla JH. Metabolic alkalosis. J Am Soc Nephrol 2000; Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (AMIB/SBPT 2013).

9

Neurologia · Ptose fatigável que alterna de olho no diabético: anticorpo antirreceptor de acetilcolina, não esperar o III nervo melhorar

Cronologia **Gabarito D**

Homem de 64 anos, diabético há 15 anos (HbA1c 8,9%) e hipertenso, procura o ambulatório por visão dupla há 5 semanas. Conta que a pálpebra esquerda 'cai' mais no fim da tarde e após ler; na última semana, em alguns dias, a queda passou a ser também à direita. Nega cefaleia, dor ocular, disfagia ou fraqueza nos membros. Exame: ptose esquerda que aumenta após 60 segundos de olhar sustentado para cima, ptose leve à direita,

limitação variável da adução e da abdução do olho esquerdo, pupilas isocóricas de 3 mm com reflexos normais; força e reflexos normais nos membros. O exame mais adequado a seguir é:

O DADO QUE DECIDE

ptose esquerda que aumenta após 60 segundos de olhar sustentado para cima

Resolução. Diabético antigo com diplopia, ptose e pupila poupada é o cenário de manual da paralisia isquêmica do III nervo, que se acompanha clinicamente e melhora em 8 a 12 semanas. Mas o tempo conta outra história: a ptose piora no fim do dia e com o uso, aumenta com o olhar sustentado (fatigabilidade), troca de lado e a limitação ocular é variável e não respeita o território de um único nervo (adução e abdução do mesmo olho). Isso é miastenia ocular. O primeiro exame é o anticorpo antirreceptor de acetilcolina (positivo em cerca de metade das formas oculares); se negativo, anti-MuSK e eletroneuromiografia de fibra única. Confirmada, pede-se TC de tórax para timoma.

A) Angiotomografia intracraniana
Errada. Seria urgente no III nervo com pupila dilatada ou dor (aneurisma de comunicante posterior); aqui a pupila é normal e o quadro flutua.

B) Hemoglobina glicada e reavaliação em 8 semanas ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a conduta na paralisia isquêmica do III nervo do diabético, que é fixa; ptose fatigável que alterna de lado não é mononeuropatia.

C) RM de órbitas com contraste
Errada. RM de órbitas procura orbitopatia ou massa, que dão déficit fixo e proptose, não fatigabilidade.

D) Anticorpo antirreceptor de acetilcolina CORRETA
Correta. Ptose e diplopia fatigáveis, flutuantes e que mudam de lado, com pupila normal: miastenia ocular, e o primeiro exame é o anticorpo.

Para levar. Ptose que piora com o uso e troca de olho, com motilidade que não respeita um nervo e pupila normal, é miastenia mesmo no diabético: anticorpo antirreceptor de acetilcolina.

International Consensus Guidance for Management of Myasthenia Gravis 2020 (Narayanaswami et al.).

10

Infectologia · Bacilos álcool-ácido resistentes em hemocultura com teste molecular para tuberculose negativo na aids avançada: complexo Mycobacterium avium

Rótulo verdadeiro

Gabarito D

Homem de 45 anos, com aids sem tratamento (CD4 18 células/mm³), tem febre diária, sudorese noturna, diarreia e perda de 12 kg em 2 meses. Exame: emagrecido, linfonodos de 1 cm em cadeias cervicais, fígado a 3 cm e baço a 5 cm do rebordo costal. Hb 7,9 g/dL, fosfatase alcalina 620 U/L (referência até 120 U/L), ALT 54 U/L. Radiografia de tórax normal. Hemocultura em meio para micobactérias, positiva no 12º dia: bacilos álcool-ácido resistentes; teste molecular rápido para M. tuberculosis (Xpert MTB/RIF) na amostra: não detectado. Antígeno urinário de Histoplasma negativo. O agente mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

teste molecular rápido para M. tuberculosis (Xpert MTB/RIF) na amostra: não detectado

Resolução. No Brasil, bacilo álcool-ácido resistente em pessoa com HIV significa tuberculose até prova em contrário, e esse é um rótulo verdadeiro na maioria dos casos. Aqui, porém, o teste molecular feito no próprio crescimento da hemocultura não detectou M. tuberculosis, o que numa cultura positiva tem alto valor preditivo negativo. O conjunto (CD4 abaixo de 50, febre e sudorese, diarreia, hepatoesplenomegalia, anemia acentuada, fosfatase alcalina muito alta e tórax normal) é o perfil da doença disseminada pelo complexo Mycobacterium avium. O tratamento é claritromicina (ou azitromicina) com etambutol, com ou sem rifabutina, e TARV iniciada em até 2 semanas. Histoplasma não é álcool-ácido resistente e o antígeno foi negativo; Bartonella não cresce como BAAR.

A) Histoplasma capsulatum
Errada. Histoplasmose disseminada daria quadro semelhante, mas o fungo não é álcool-ácido resistente e o antígeno urinário foi negativo.

B) Mycobacterium tuberculosis ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria a resposta com teste molecular positivo; Xpert não detectado em cultura positiva praticamente exclui M. tuberculosis.

C) Bartonella henselae
Errada. Bartonella causa angiomatose bacilar e peliose hepática, mas não cresce como bacilo álcool-ácido resistente em meio para micobactérias.

D) Complexo Mycobacterium avium CORRETA
Correta. BAAR em hemocultura, Xpert negativo, CD4 abaixo de 50, hepatoesplenomegalia e fosfatase alcalina alta: MAC disseminado.

Para levar. BAAR em hemocultura de pessoa com HIV e CD4 abaixo de 50 com teste molecular para tuberculose negativo: complexo Mycobacterium avium (claritromicina e etambutol).

NIH/CDC/IDSA Guidelines for Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV (Mycobacterium avium Complex Disease); PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (MS).

11

Hematologia · Trombose de veia safena de 8 cm a 6 cm da junção: fondaparinux profilático por 45 dias

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 56 anos, com varizes de membros inferiores, tem há 3 dias dor, vermelhidão e cordão endurecido na face medial da coxa esquerda, sem trauma, sem acesso venoso e sem febre. Ultrassonografia: trombose da veia safena magna em extensão de 8 cm, com extremidade proximal a 6 cm da junção safenofemoral; veias profundas sem trombose. Sem câncer, sem trombose prévia, sem uso de hormônios. Plaquetas e função renal normais (TFGe 90 mL/min/1,73 m²), sem sangramento. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE
em extensão de 8 cm

Resolução. Tromboflebite superficial parece doença benigna, de compressa e anti-inflamatório, e o apressado não anticoagula. Mas o que decide é a extensão e a distância das junções: trombose de veia superficial com 5 cm ou mais de extensão tem risco relevante de progressão para TVP e TEP, e o estudo CALISTO mostrou que fondaparinux 2,5 mg/dia por 45 dias reduz esses eventos. Esta tem 8 cm, e a extremidade está a mais de 3 cm da junção safenofemoral, então a dose é profilática. Anticoagulação plena

por 3 meses ficaria para o trombo a 3 cm ou menos da junção, tratado como TVP. A ligadura cirúrgica não supera a anticoagulação e tem mais complicações.

A) Anticoagulação plena por 3 meses
Errada. Dose plena por 3 meses é para trombo a 3 cm ou menos da junção safenofemoral ou safenopoplítea, tratado como TVP.

B) Ligadura da junção safenofemoral
Errada. A ligadura da junção não é superior à anticoagulação e acrescenta risco cirúrgico.

C) Fondaparinux 2,5 mg/dia por 45 dias CORRETA
Correta. Trombose superficial de 5 cm ou mais e a mais de 3 cm da junção: fondaparinux 2,5 mg/dia por 45 dias.

D) AINE tópico e compressão apenas ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Só tratamento sintomático é para trombose superficial menor que 5 cm e distante das junções.

Para levar. Trombose venosa superficial com 5 cm ou mais: fondaparinux 2,5 mg por 45 dias; a 3 cm ou menos da junção safenofemoral, anticoagulação plena como TVP.

CHEST 2016 Antithrombotic Therapy for VTE (Kearon et al.); ESVS 2021 Clinical Practice Guidelines on venous thrombosis (Kakkos et al.); Decousus et al., CALISTO, NEJM 2010.

12

Cardiologia · Anomalia de Ebstein no adulto com pré-excitação e exposição intrauterina ao lítio: B1 amplamente desdobrada e insuficiência tricúspide

Rótulo verdadeiro | Gabarito C

Mulher de 23 anos procura atendimento por crises de taquicardia regular, de início e fim súbitos, desde a adolescência, revertidas com manobra vagal, e cansaço aos esforços moderados. A mãe tem transtorno bipolar e usou o mesmo estabilizador de humor durante toda a gestação. Exame: discreta cianose labial, SpO2 de 92% em repouso, sem baqueteamento digital; PA 104×68 mmHg; pulso venoso jugular sem onda v proeminente; B1 amplamente desdobrada, com componente tardio intenso; B2 com componente pulmonar normal; sopro holossistólico suave na borda esternal esquerda baixa que aumenta na inspiração. ECG de repouso: ondas P altas e apiculadas em DII, PR de 100 ms e onda delta. Radiografia: área cardíaca aumentada à custa de átrio direito, com trama vascular pulmonar diminuída. A cardiopatia de base mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

B1 amplamente desdobrada, com componente tardio intenso

Resolução. Taquicardia paroxística com PR curto e onda delta encaixa em Wolff-Parkinson-White, e quem para nesse rótulo verdadeiro trata a via e ignora o resto, que é a armadilha. Só que a via acessória não explica cianose, átrio direito gigante, trama pulmonar diminuída nem a ausculta. B1 amplamente desdobrada com componente tardio alto (o fechamento do grande folheto anterior da tricúspide, o 'som de vela'), sopro de insuficiência tricúspide que aumenta na inspiração e P alta em DII compõem a anomalia de Ebstein: deslocamento apical dos folhetos septal e posterior da tricúspide, atrialização do ventrículo direito, átrio direito enorme e complacente (por isso a onda v não aparece no pulso jugular) e shunt direita-esquerda pelo forame oval ou CIA, que dá a cianose. Vias acessórias, quase sempre direitas, ocorrem em 10 a 30% dos casos. A exposição intrauterina ao lítio é a associação que a prova cobra, embora o risco absoluto seja baixo.

A) Comunicação interatrial com síndrome de Eisenmenger
Errada. No Eisenmenger a P2 é hiperfonética e há sinais de hipertensão pulmonar; aqui a P2 é normal e a trama pulmonar está diminuída.

B) Estenose pulmonar valvar grave
Errada. A estenose pulmonar grave dá sopro ejetivo em foco pulmonar com P2 diminuída e hipertrofia de ventrículo direito, e não sopro regurgitante tricúspide com átrio direito gigante.

C) Anomalia de Ebstein com via acessória CORRETA
Correta. Ausculta de B1 desdobrada com componente tardio alto, insuficiência tricúspide, átrio direito gigante, cianose por shunt direita-esquerda e via acessória direita formam a anomalia de Ebstein.

D) Síndrome de Wolff-Parkinson-White isolada ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. A via acessória é real, mas isolada não explica cianose, cardiomegalia à custa de átrio direito, trama diminuída e ausculta tricúspide.

Para levar. Ebstein: B1 amplamente desdobrada (som de vela), insuficiência tricúspide, átrio direito gigante, cianose por shunt atrial e via acessória direita; associação com lítio intrauterino.

ESC 2020 (adult congenital heart disease); ACC/AHA 2018 (adult congenital heart disease)

13

Endocrinologia · Hirsutismo desde a puberdade com 17-OH-progesterona basal entre 200 e 1.000: teste com ACTH para a forma não clássica da hiperplasia adrenal

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 24 anos tem hirsutismo progressivo desde a menarca, aos 11 anos, acne e ciclos menstruais irregulares. A mãe conta que surgiram pelos pubianos aos 7 anos. Não há engrossamento da voz nem clitoromegalia. IMC 23 kg/m², sem acantose, PA normal. Exames coletados às 8 horas, na fase folicular: 17-OH-progesterona 520 ng/dL (VR até 200), testosterona total 78 ng/dL (VR até 45), DHEA-S normal, prolactina e TSH normais, beta-hCG negativo. Ultrassonografia pélvica: ovários com 14 folículos cada. O próximo exame a ser solicitado é:

O DADO QUE DECIDE

17-OH-progesterona 520 ng/dL (VR até 200)

Resolução. Hirsutismo, acne, ciclos irregulares e ovários multifoliculares levam ao rótulo de SOP, mas a SOP é diagnóstico de exclusão, e a pubarca precoce já aponta outra coisa. O dado que decide é a 17-OH-progesterona basal coletada da forma correta (8 horas, fase folicular): acima de 200 ng/dL obriga a excluir hiperplasia adrenal congênita não clássica por deficiência de 21-hidroxilase; abaixo de 200, praticamente a afasta; acima de cerca de 1.000, fecha o diagnóstico. Entre 200 e 1.000, como aqui, o passo seguinte é o teste com ACTH sintético (cortrosina 250 mcg), e um valor estimulado acima de 1.000 ng/dL confirma. O sequenciamento do CYP21A2 vem depois, para aconselhamento genético e planejamento de gestação, e não para o diagnóstico inicial. Tomografia não tem papel, porque a doença é enzimática e as adrenais podem até estar normais.

A) Supressão com dexametasona 1 mg
Errada. Rastreia síndrome de Cushing, sem fenótipo aqui; não confirma nem afasta a hiperplasia adrenal.

B) Tomografia de adrenais
Errada. Imagem adrenal serve para tumor virilizante (DHEA-S alto, virilização rápida); na hiperplasia o defeito é enzimático.

C) 17-OH-progesterona após ACTH sintético CORRETA
Correta. 17-OH-progesterona basal de 520, na faixa entre 200 e 1.000: o teste com ACTH sintético define a forma não clássica (estimulada acima de 1.000).

D) Sequenciamento do gene CYP21A2 ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a genotipagem confirma o alelo e orienta o aconselhamento genético, mas é o degrau seguinte, e não o exame diagnóstico inicial.

Para levar. 17-OH-progesterona basal (8 horas, fase folicular): abaixo de 200 afasta, acima de 1.000 confirma e, entre 200 e 1.000, faça o teste com ACTH; genótipo só depois.

Endocrine Society 2018 (Congenital adrenal hyperplasia due to steroid 21-hydroxylase deficiency); Endocrine Society 2018 (Hirsutism in premenopausal women).

---

14 Alergia · Asma com polipose nasal e broncoespasmo após ibuprofeno: inibidor seletivo da COX-2 é o anti-inflamatório tolerado

Dado omitido **Gabarito A**

Mulher de 44 anos com asma moderada em uso de budesonida-formoterol e rinossinusite crônica com polipose nasal, operada duas vezes, relata que há 2 anos, cerca de 40 minutos após tomar ibuprofeno para cólica, teve obstrução nasal, rinorreia e crise de broncoespasmo com atendimento de emergência. Desde então evita anti-inflamatórios. Agora tem tendinite do ombro, com dor que não cede ao paracetamol 750 mg. Asma controlada, VEF1 de 82% do previsto. O anti-inflamatório mais seguro para esta paciente é:

O DADO QUE DECIDE
rinossinusite crônica com polipose nasal, operada duas vezes

Resolução. A palavra aspirina não aparece, mas asma, polipose nasal e reação respiratória a um AINE formam a doença respiratória exacerbada por AINE. Nela a reação não é alergia ao ibuprofeno: é efeito farmacológico da inibição da COX-1, que desvia o ácido araquidônico para leucotrienos, e por isso há reatividade cruzada com todos os inibidores fortes da COX-1. No Brasil a dipirona é vista como alternativa segura, mas também inibe a COX-1 e desencadeia crises nesses pacientes. Os inibidores seletivos da COX-2 (celecoxibe, etoricoxibe) são tolerados pela grande maioria e são a escolha, de preferência com a primeira dose sob observação; paracetamol em dose até 500 a 650 mg também costuma ser tolerado.

A) Celecoxibe CORRETA
Correta. Inibidor seletivo da COX-2 é tolerado pela grande maioria dos pacientes com doença respiratória exacerbada por AINE.

B) Naproxeno
Errada. Inibe fortemente a COX-1 e tem reatividade cruzada com o ibuprofeno.

C) Diclofenaco
Errada. Inibidor não seletivo potente, com o mesmo mecanismo da reação ao ibuprofeno.

D) Dipirona ARMADILHA

Errada. Tida como segura por hábito, também inibe a COX-1 e desencadeia reações nesses pacientes.

Para levar. Asma, polipose nasal e reação respiratória a AINE: reatividade cruzada com todo inibidor forte da COX-1, dipirona incluída; use inibidor seletivo da COX-2.

EAACI/ENDA position paper on NSAID hypersensitivity (2019); GINA 2024 (asma e doença respiratória exacerbada por AINE).

---

15 Gastroenterologia · Hemorragia por variz gástrica isolada de fundo (IGV1) no cirrótico: cianoacrilato, e não ligadura elástica

Qualificador **Gabarito B**

Homem de 57 anos, com cirrose por hepatite C tratada (Child-Pugh B8), é admitido por hematêmese volumosa. PA 96 × 58 mmHg após 1.000 mL de cristaloide e um concentrado de hemácias (Hb 7,4 g/dL), FC 108 bpm. Recebeu terlipressina, ceftriaxona e eritromicina antes da endoscopia, feita em 8 horas, com o paciente intubado para proteção da via aérea. Endoscopia: varizes esofágicas de fino calibre, sem estigmas, que não se continuam para o estômago; no fundo gástrico, variz isolada de grosso calibre com mamilo de fibrina e coágulo aderido. Doppler recente com veia esplênica pérvia. No mesmo exame, a terapia endoscópica mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

no fundo gástrico, variz isolada de grosso calibre com mamilo de fibrina

Resolução. A ligadura elástica é a terapia endoscópica de escolha na hemorragia por varizes esofágicas, e o reflexo é estendê-la a toda variz. O qualificador do comando (a terapia endoscópica, no mesmo exame) e o dado da endoscopia mudam a resposta: a fonte é uma variz gástrica isolada de fundo (IGV1), sem continuidade com as esofágicas, que são finas e sem estigmas. Nas varizes de fundo (IGV1 e GOV2), as varizes são grossas e de fluxo alto, a ligadura captura mal a parede e a queda da banda causa úlcera com ressangramento; o Baveno VII recomenda injeção de adesivo tissular (cianoacrilato). A escleroterapia tem eficácia baixa e mais ressangramento nesse território. Controlado o sangramento, TIPS ou obliteração retrógrada são opções para a prevenção do ressangramento, e a veia esplênica pérvia afasta a hipertensão portal segmentar.

A) Escleroterapia da variz com etanolamina

Errada. A escleroterapia tem baixa eficácia e mais ressangramento nas varizes gástricas; não é a primeira escolha.

B) Cianoacrilato injetado na variz gástrica CORRETA

Correta. Variz gástrica isolada de fundo (IGV1) sangrante: injeção de cianoacrilato, recomendada pelo Baveno VII.

C) Ligadura elástica das varizes esofágicas

Errada. Seria a conduta se o sangramento viesse das varizes esofágicas; aqui elas são finas e sem estigmas, e o mamilo está na variz de fundo.

D) Ligadura elástica da variz gástrica ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a escolha para varizes esofágicas ou GOV1 pequenas; na variz isolada de fundo, de grosso calibre, ressangra mais que o cianoacrilato.

Para levar. Na hemorragia por variz gástrica de fundo (IGV1 ou GOV2), a terapia endoscópica é o cianoacrilato; a ligadura é para as esofágicas.

Baveno VII (de Franchis et al., J Hepatol 2022); AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis (Kaplan et al., Hepatology 2024).

---

16 Pneumologia · Carcinoma de pequenas células com linfonodos mediastinais contralaterais: ainda doença limitada

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 64 anos, tabagista de 55 maços-ano, tem tosse e emagrecimento de 4 kg. TC: massa hilar direita de 5 cm, linfonodos paratraqueais aumentados dos dois lados do mediastino e linfonodo supraclavicular direito de 1,8 cm, cuja punção mostrou carcinoma de pequenas células. PET-CT e ressonância de crânio: nenhuma lesão fora do tórax e da fossa supraclavicular direita; não há derrame pleural nem pericárdico. Sódio 128 mEq/L, com euvolemia e osmolalidade urinária alta. ECOG 1, função pulmonar adequada para radioterapia. A classificação da doença e o tratamento mais adequados são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

nenhuma lesão fora do tórax e da fossa supraclavicular direita

Resolução. Linfonodos mediastinais contralaterais e supraclavicular parecem doença avançada e puxam para o esquema da doença extensa, com quimioterapia e imunoterapia. Mas no carcinoma de pequenas células a divisão que manda é se toda a doença cabe num campo de radioterapia com segurança: linfonodos mediastinais dos dois lados e supraclavicular homolateral ainda são doença limitada (estádio III, sem metástase à distância), e a SIADH é paraneoplásica, não metástase. A doença limitada com bom desempenho recebe quimiorradioterapia concomitante (platina com etoposídeo e radioterapia torácica), seguida de consolidação com durvalumabe (ADRIATIC) e de profilaxia ou vigilância do crânio. Cirurgia só se aplica ao estádio I, sem linfonodos.

A) Limitada / lobectomia e quimioterapia adjuvante
Errada. Ressecção cabe no carcinoma de pequenas células T1-2 N0; com N3 não há papel cirúrgico.

B) Limitada / quimiorradioterapia concomitante CORRETA
Correta. Doença restrita ao tórax e à fossa supraclavicular homolateral, cabível num campo de radioterapia: limitada, quimiorradioterapia concomitante.

C) Extensa / quimioterapia com imunoterapia ARMADILHA
Errada. É o tratamento da doença extensa (metástase à distância, derrame maligno); aqui não há nada fora do campo irradiável.

D) Extensa / radioterapia paliativa
Errada. Radioterapia isolada é paliativa e não cura; o paciente tem ECOG 1 e doença potencialmente curável.

Para levar. Carcinoma de pequenas células: limitado é o que cabe num campo de radioterapia (inclui mediastino contralateral e supraclavicular homolateral) e recebe quimiorradioterapia concomitante; extenso recebe quimioterapia com imunoterapia.

NCCN Small Cell Lung Cancer v.2025; ADRIATIC (Cheng et al., N Engl J Med 2024); ESMO SCLC Guideline 2021.

17

Nefrologia · Acidose com ânion gap alto após bebedeira e jejum, com cetonas em traço na fita · beta-hidroxibutirato revela cetoacidose alcoólica

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 44 anos, etilista, interrompeu a bebida há 2 dias, depois de uma semana de consumo intenso, por vômitos repetidos e dor abdominal; não se alimenta desde então. Não tem diabetes e não usa medicações. Lúcido, sem queixa visual, PA 104/66 mmHg, FC 112 bpm, fundo de olho normal. Exames: glicose 92 mg/dL, sódio 136 mEq/L, cloro 100 mEq/L, bicarbonato 12 mEq/L, pH 7,27, pCO2 27 mmHg, lactato 2,4 mmol/L, creatinina 1,1 mg/dL, ureia 40 mg/dL, etanol sérico indetectável, osmolalidade medida de 290 mOsm/kg e calculada de 284 mOsm/kg, lipase normal. A fita urinária mostra cetonas apenas em traço; o beta-hidroxibutirato sérico é de 6,2 mmol/L. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

o beta-hidroxibutirato sérico é de 6,2 mmol/L

Resolução. Etilista com acidose de ânion gap alto (24) e cetonas em traço na fita: o apressado descarta cetoacidose e corre para álcool tóxico. A fita urinária usa nitroprussiato, que detecta acetoacetato e não beta-hidroxibutirato; na cetoacidose alcoólica, o excesso de NADH do metabolismo do etanol desvia quase toda a cetona para beta-hidroxibutirato, e a fita subestima a cetose. O beta-hidroxibutirato de 6,2 mmol/L confirma a cetoacidose, e o contexto (bebedeira, parada abrupta, vômitos, jejum, glicose normal) define a alcoólica. O metanol fica afastado pelo gap osmolar de 6, pela visão e pelo fundo de olho normais, e o lactato de 2,4 não explica um ânion gap de 24. A cetoacidose de jejum isolada raramente baixa o bicarbonato abaixo de 18 mEq/L. O tratamento é tiamina, soro glicosado com salina e reposição de potássio, fósforo e magnésio, sem insulina.

A) Cetoacidose de jejum
Errada. O jejum isolado gera cetose leve, com bicarbonato raramente abaixo de 18 mEq/L; bicarbonato de 12 e beta-hidroxibutirato de 6,2 pedem o contexto alcoólico.

B) Cetoacidose alcoólica CORRETA
Correta. Bebedeira seguida de vômitos e jejum, glicose normal, beta-hidroxibutirato alto e fita falsamente tranquilizadora.

C) Acidose lática por deficiência de tiamina
Errada. Seria considerada com lactato muito elevado no etilista desnutrido; lactato de 2,4 mmol/L não explica um ânion gap de 24.

D) Intoxicação por metanol ARMADILHA
Errada. Teria gap osmolar alto (acima de 10 a 15) no início, queixa visual e alteração no fundo de olho; o gap é 6 e a visão é normal.

Para levar. Na cetoacidose alcoólica a fita urinária (nitroprussiato) subestima a cetose porque predomina o beta-hidroxibutirato: dose-o no sangue. Glicose normal, tratamento com tiamina e glicose, sem insulina.

Kraut JA, Madias NE. Metabolic acidosis: pathophysiology, diagnosis and management. Nat Rev Nephrol 2010; Long B et al. Alcoholic ketoacidosis: etiologies, evaluation, and management. J Emerg Med 2021.

18

Neurologia · Variante comportamental da demência frontotemporal rotulada como bipolar: ISRS para o comportamento, não anticolinesterásico

Grade X / Y

Gabarito B

Homem de 59 anos, engenheiro, é trazido pela esposa porque em 18 meses 'virou outra pessoa': faz comentários sexuais a desconhecidas, gastou as economias em compras impulsivas, come doces compulsivamente (ganhou 9 kg), perdeu a empatia com os netos e repete rituais de abrir e fechar portas. Recebeu diagnóstico de transtorno bipolar há 1 ano, sem resposta ao lítio. Está orientado, lembra-se de fatos recentes e acerta o trajeto até o consultório; nega tristeza. MoCA 25/30, com perdas em fluência verbal e abstração. Sem sinais motores. RM: atrofia frontal e temporal anterior bilateral, predominante à direita, com hipocampos relativamente preservados. O diagnóstico e o tratamento farmacológico mais adequado para os sintomas comportamentais são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

atrofia frontal e temporal anterior bilateral, predominante à direita

Resolução. O diagnóstico é a variante comportamental da demência frontotemporal: início antes dos 65 anos, desinibição, compras impulsivas, hiperoralidade, perda de empatia e comportamentos compulsivos, com memória e orientação espacial relativamente preservadas, e atrofia frontal e temporal anterior com hipocampos poupados. O rótulo de transtorno bipolar tardio sem resposta ao lítio é a forma mais comum de atraso diagnóstico. A segunda metade é a armadilha: o raciocínio 'demência, então anticolinesterásico' falha aqui, porque não há déficit colinérgico na degeneração frontotemporal, e donepezila não melhora e pode piorar a agitação. Para desinibição e compulsões usam-se ISRS (ou trazodona); antipsicótico só em dose baixa e com cautela.

A) Doença de Alzheimer / donepezila
Errada. Alzheimer começa por memória episódica com atrofia hipocampal; aqui a memória está relativamente preservada e os hipocampos poupados.

B) Demência frontotemporal / ISRS CORRETA
Correta. Quadro comportamental com atrofia frontotemporal; ISRS reduz desinibição e compulsões.

C) Demência frontotemporal / donepezila ARMADILHA
Errada, é a armadilha. O diagnóstico está certo, mas anticolinesterásicos não funcionam na demência frontotemporal e podem agravar o comportamento.

D) Doença de Alzheimer / ISRS
Errada. O ISRS seria aceitável para sintomas, mas o diagnóstico não é Alzheimer.

Para levar. Demência frontotemporal comportamental: memória poupada, atrofia frontal e temporal anterior; trata-se o comportamento com ISRS ou trazodona, e anticolinesterásico não serve.

Rascovsky et al., critérios internacionais da variante comportamental da DFT (Brain 2011); Recomendações da Academia Brasileira de Neurologia para diagnóstico e tratamento das demências (Dement Neuropsychol, 2022).

---

19 Infectologia · Cancroide com sorologias não reagentes: azitromicina em dose única e repetição de sífilis e HIV em 3 meses

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 26 anos tem há 8 dias três úlceras dolorosas no sulco balanoprepucial, de bordas irregulares e solapadas, fundo purulento e friável, base mole, que sangram ao toque. Há 3 dias surgiu linfonodo inguinal direito de 4 cm, doloroso, com flutuação central e pele eritematosa, sem fistulização. Teve relação sem preservativo com parceira casual há 2 semanas. VDRL e teste treponêmico rápido não reagentes; anti-HIV não reagente; PCR para herpes simples na úlcera negativo. O tratamento antimicrobiano e a conduta quanto às sorologias para sífilis e HIV são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Teve relação sem preservativo com parceira casual há 2 semanas

Resolução. Úlceras múltiplas, dolorosas, de bordas solapadas e fundo purulento, com bubão inguinal unilateral flutuante, e herpes e sífilis afastados, são cancroide (Haemophilus ducreyi); os testes para sífilis foram colhidos com 8 dias de úlcera, acima dos 7 dias que o critério diagnóstico do CDC exige. O bubão volumoso atrai para o linfogranuloma venéreo, mas no linfogranuloma a lesão de entrada é pequena, indolor e fugaz, e o bubão drena por múltiplos orifícios. O tratamento do cancroide é azitromicina 1 g em dose única (ou ceftriaxona 250 mg IM), com aspiração por agulha do linfonodo flutuante quando tenso. A segunda decisão vem do tempo: a exposição foi há 2 semanas, dentro da janela da sífilis e do HIV, e úlcera genital aumenta a transmissão do HIV; a recomendação é repetir os testes de sífilis e HIV 3 meses depois quando inicialmente negativos, e tratar as parcerias dos últimos 10 dias.

A) Azitromicina 1 g dose única / não repetir
Errada. Acerta o antimicrobiano, mas sorologias negativas 2 semanas após a exposição podem estar na janela e devem ser repetidas.

B) Azitromicina 1 g dose única / repetir em 3 meses CORRETA
Correta. Cancroide: azitromicina 1 g dose única; repetir testes de sífilis e HIV em 3 meses.

C) Doxiciclina por 21 dias / repetir em 3 meses ARMADILHA
Errada. É a armadilha: doxiciclina por 21 dias trata linfogranuloma, cuja úlcera é indolor e fugaz e cujo bubão fistuliza por múltiplos orifícios.

D) Penicilina benzatina / não repetir
Errada. Penicilina benzatina trataria sífilis primária, de úlcera única, indolor e de base endurecida, com testes que já podem ser reagentes.

Para levar. Cancroide: azitromicina 1 g dose única (ou ceftriaxona IM); testes de sífilis e HIV negativos no diagnóstico de úlcera genital se repetem em 3 meses.

CDC Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines (2021), Chancroid; PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST (MS, 2022).

---

20 Oncologia · Rastreamento do câncer colorretal com pai acometido aos 52 anos: colonoscopia aos 40, a cada 5 anos

Cronologia **Gabarito B**

Homem de 36 anos, assintomático, cujo pai teve adenocarcinoma de cólon aos 52 anos (sem síndrome hereditária identificada); não há outros casos na família. Quanto ao rastreamento do câncer colorretal, o início e o intervalo da colonoscopia são:

O DADO QUE DECIDE

pai teve adenocarcinoma de cólon aos 52 anos

Resolução. A regra dos 10 anos antes do caso índice é a mais lembrada, e 52 menos 10 dá 42 anos. Mas a regra completa é iniciar aos 40 anos ou 10 anos antes da idade do parente mais jovem ao diagnóstico, o que vier primeiro: aqui 40 vem antes de 42. Com um parente de primeiro grau diagnosticado antes dos 60 anos, o exame é colonoscopia, repetida a cada 5 anos. Com parente de primeiro grau após os 60, o rastreamento segue o da população geral a partir dos 40 a 45 anos. Começar agora, aos 36, seria a regra da síndrome de Lynch, não confirmada.

A) Aos 45 anos, a cada 10 anos
Errada. É o rastreamento da população de risco médio, que não se aplica a filho de quem teve câncer antes dos 60 anos.

B) Aos 40 anos, a cada 5 anos CORRETA
Correta. Parente de primeiro grau com câncer antes dos 60: colonoscopia aos 40 ou 10 anos antes, o que vier primeiro, a cada 5 anos.

C) Aos 42 anos, a cada 5 anos ARMADILHA
Errada. Aplica só a metade da regra (10 anos antes do caso índice); 40 anos vem antes de 42.

D) Agora, a cada 3 anos
Errada. Início imediato com intervalo curto é para síndrome de Lynch, aqui sem indício.

Para levar. Parente de primeiro grau com câncer colorretal antes dos 60 anos: colonoscopia aos 40 ou 10 anos antes do caso mais jovem (o que vier primeiro), a cada 5 anos.

US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer: Recommendations for Follow-up and Screening in Familial Risk (2017); ACG Clinical Guidelines: Colorectal Cancer Screening (2021)

---

21 Hematologia · Plaquetopenia de 31.000 em pré-operatório sem nenhum sangramento e grumos no laudo: pseudoplaquetopenia por EDTA

Negativo no meio **Gabarito D**

Homem de 52 anos, em pré-operatório de colecistectomia, tem hepatite C tratada com resposta virológica sustentada há 4 anos, sem cirrose à elastografia (5,8 kPa). Assintomático. O hemograma automatizado mostrou plaquetas de 31.000/mm³, com Hb e leucócitos normais; repetido em novo tubo de tampa roxa, 28.000/mm³. Nunca teve sangramento, inclusive em hernioplastia há 3 anos e em extrações dentárias. Exame físico sem petéquias, equimoses ou esplenomegalia. TP e TTPa normais. Ultrassonografia: fígado e baço normais. Não usa medicamentos. O laudo do esfregaço descreve plaquetas agrupadas nas bordas da lâmina. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

plaquetas agrupadas nas bordas da lâmina

Resolução. O vírus C é um rótulo verdadeiro: causa PTI secundária e, com cirrose, hiperesplenismo. Mas a infecção foi curada há 4 anos, o fígado não é cirrótico e o baço é normal. Com 30.000 plaquetas reais, petéquias e sangramento seriam esperados, e ele não tem nenhum, nem em cirurgias recentes. A repetição no mesmo tipo de tubo não ajuda, porque o EDTA (tampa roxa) é a causa: em cerca de 0,1% das pessoas, autoanticorpos dependentes do EDTA aglutinam as plaquetas in vitro, e o contador não conta os grumos. O laudo de plaquetas agrupadas fecha o diagnóstico, confirmado pela contagem em tubo de citrato ou heparina. A cirurgia pode prosseguir sem transfusão nem investigação adicional.

A) Hiperesplenismo por hepatopatia
Errada. Hiperesplenismo exige hipertensão portal com baço aumentado; a elastografia e o baço são normais.

B) PTI secundária ao vírus C ARMADILHA
Errada, é a armadilha. O HCV causa PTI, mas a infecção foi curada, ele nunca sangrou e o esfregaço mostra grumos.

C) Plaquetopenia por fármaco
Errada. Ele não usa medicamentos.

D) Pseudoplaquetopenia por EDTA CORRETA
Correta. Plaquetopenia sem nenhum sangramento, repetida no mesmo tubo e com grumos no esfregaço: artefato do EDTA, confirmado em citrato.

Para levar. Plaquetopenia sem sangramento, com grumos no esfregaço, é pseudoplaquetopenia por EDTA: recontar em citrato antes de qualquer investigação ou transfusão.

Lardinois et al., Pseudothrombocytopenia: a review, Int J Lab Hematol 2021; ASH 2019 Guidelines for ITP (Neunert et al.).

---

22 Reumatologia · Pancitopenia, miopatia e neuropatia em gotoso com DRC após erradicação do H. pylori: intoxicação por colchicina pelo macrolídeo

Droga a deduzir **Gabarito C**

Homem de 68 anos, com gota e doença renal crônica (taxa de filtração glomerular estimada de 38 mL/min/1,73 m²), usa alopurinol 200 mg/dia há 2 anos, colchicina 0,5 mg duas vezes ao dia como profilaxia e atorvastatina 40 mg/dia. Há 12 dias iniciou esquema de 14 dias para erradicação do Helicobacter pylori, com omeprazol,

amoxicilina e um macrolídeo. Há 5 dias tem diarreia aquosa, vômitos, fraqueza proximal progressiva e parestesias nos pés. Exame: desidratado, força grau 3 proximal, reflexos aquileus abolidos. Exames: leucócitos 2.100/mm³, plaquetas 68.000/mm³, Hb 11,2 g/dL, CK 4.800 U/L, creatinina 2,1 mg/dL (era 1,7), K 4,9 mEq/L. A causa mais provável do quadro é:

O DADO QUE DECIDE

omeprazol, amoxicilina e um macrolídeo

Resolução. O macrolídeo do esquema é a claritromicina, inibidor potente do CYP3A4 e da glicoproteína P, e isso eleva tanto a atorvastatina quanto a colchicina. A miopatia por estatina potencializada é real e explica a CK, mas não explica diarreia, pancitopenia e neuropatia com arreflexia. A colchicina, cuja eliminação já está reduzida pela doença renal crônica, acumula com a claritromicina e produz o quadro completo da intoxicação: fase gastrointestinal, depois mielossupressão, miopatia com CK alta e neuropatia axonal (neuromiopatia). A conduta é suspender colchicina, macrolídeo e estatina, suporte e vigilância das citopenias. A interação é tão grave que a associação de colchicina com claritromicina é contraindicada na doença renal ou hepática.

A) Miopatia por atorvastatina potencializada ARMADILHA
Errada. A claritromicina eleva a atorvastatina e explica a CK, mas não a diarreia, a pancitopenia e a neuropatia.

B) Colite por Clostridioides difficile
Errada. Explicaria a diarreia após antibiótico, mas não a pancitopenia, a CK de 4.800 e a arreflexia.

C) Intoxicação por colchicina CORRETA
Correta. Claritromicina mais DRC elevam a colchicina: diarreia, pancitopenia, miopatia e neuropatia.

D) DRESS pelo alopurinol
Errada. Alopurinol em uso há 2 anos, fora da janela, e sem exantema, eosinofilia ou hepatite.

Para levar. Colchicina com claritromicina (ou outro inibidor forte do CYP3A4) na DRC: diarreia, citopenias e neuromiopatia; a associação é contraindicada.

2020 ACR Guideline for the Management of Gout; bula da colchicina (ANVISA/FDA, interações com inibidores do CYP3A4 e da P-gp); IV Consenso Brasileiro sobre a infecção pelo H. pylori (2018).

---

23 Endocrinologia · Fibrilação atrial e TSH suprimido em idosa tireoidectomizada que "trocou o comprimido de jejum": excesso de levotiroxina, com tireoglobulina indetectável

Droga a deduzir

Gabarito C

Mulher de 76 anos é trazida pela filha por palpitações há 3 semanas. Foi operada da tireoide há 22 anos (retirada de um dos lobos por "caroço benigno") e desde então toma "um comprimido em jejum". Há 4 meses, ao queixar-se de cansaço a outro médico, teve todas as receitas refeitas. Perdeu 3 kg e anda mais ansiosa. Exame: FC 118 bpm irregular, PA 138 × 76 mmHg, cicatriz cervical antiga, sem bócio ou nódulo palpável, sem oftalmopatia, tremor fino. ECG: fibrilação atrial. Exames: TSH 0,02 mUI/L (VR 0,4 a 4,0), T4 livre 2,1 ng/dL (VR 0,9 a 1,8), T3 livre no limite superior, tireoglobulina sérica indetectável com anticorpo antitireoglobulina negativo, VHS normal. A causa mais provável da tireotoxicose é:

O DADO QUE DECIDE

tireoglobulina sérica indetectável com anticorpo antitireoglobulina negativo

Resolução. Idosa com fibrilação atrial e TSH suprimido puxa bócio multinodular tóxico, a causa mais comum de hipertireoidismo nessa faixa, e o reflexo é a cintilografia. A droga não está nomeada e precisa ser deduzida: quem foi operado da tireoide e toma "um comprimido em jejum" há 22 anos usa levotiroxina, e as receitas foram refeitas há 4 meses por um sintoma inespecífico, o momento em que uma dose costuma mudar sem que o paciente perceba. A tireoglobulina confirma: toda tireotoxicose de origem glandular (nódulo autônomo, Graves, tireoidite) libera tireoglobulina, enquanto o hormônio exógeno suprime o lobo remanescente e a tireoglobulina fica indetectável, desde que o anticorpo antitireoglobulina seja negativo (que falsearia a dosagem). A conduta é reduzir a levotiroxina para a dose anterior, controlar a frequência e anticoagular conforme o risco, e repetir TSH em 6 a 8 semanas; cintilografia seria exame a mais.

A) Tireoidite silenciosa

Errada. Tireoidite libera hormônio pré-formado e tireoglobulina em grande quantidade; tireoglobulina indetectável a afasta.

B) Doença de Graves de início tardio

Errada. Graves é raro aos 76 anos sem bócio nem oftalmopatia e, como toda fonte glandular, teria tireoglobulina detectável.

C) Excesso de levotiroxina CORRETA

Correta. Comprimido de jejum desde a lobectomia, receitas refeitas há 4 meses e tireoglobulina indetectável com anticorpo negativo apesar do lobo remanescente: tireotoxicose por levotiroxina.

D) Bócio multinodular tóxico no lobo remanescente ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o lobo remanescente pode desenvolver nódulo autônomo, mas ele liberaria tireoglobulina, que estaria normal ou alta; não há nódulo palpável, e as receitas foram refeitas há 4 meses.

Para levar. Tireotoxicose com tireoglobulina indetectável (anticorpo negativo) é hormônio exógeno; no idoso em levotiroxina com fibrilação atrial, reduza a dose antes de investigar nódulo.

ATA 2016 (Guidelines for the diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis); ATA 2014 (Guidelines for the treatment of hypothyroidism); Brenta G et al., Arq Bras Endocrinol Metabol 2013 (Diretrizes clínicas práticas para o manejo do hipotireoidismo).

---

24 Cardiologia · Dissecção espontânea de coronária no puerpério com fluxo preservado: tratamento conservador, sem angioplastia

Omissão **Gabarito C**

Mulher de 38 anos, no 40º dia após parto normal, amamentando, sem fatores de risco cardiovascular, tem dor retroesternal intensa iniciada há 3 horas, após uma discussão familiar. ECG: infradesnivelamento de ST de V2 a V5, sem supradesnivelamento. Troponina elevada. Cateterismo realizado em 4 horas: artéria descendente anterior com estreitamento longo, liso e progressivo do terço médio ao distal, sem placas ateroscleróticas em outros segmentos, com fluxo TIMI 3; artérias coronárias de aspecto tortuoso. Na saída da sala, está sem dor, PA 118×70 mmHg, FC 76 bpm, sem arritmias, fração de ejeção de 55%. Além de betabloqueador, a conduta para a lesão coronariana é:

O DADO QUE DECIDE

estreitamento longo, liso e progressivo do terço médio ao distal

Resolução. Infarto sem supra com lesão na descendente anterior leva o apressado a tratar a lesão com stent, que é a armadilha. O aspecto angiográfico decide: estreitamento longo, liso e progressivo, sem placa em outros segmentos, numa puérpera sem fatores de risco, com tortuosidade coronária, é dissecção espontânea de coronária tipo 2 (hematoma intramural). Na dissecção, a angioplastia tem alta taxa de complicação (propagação do hematoma, dissecção iatrogênica, má aposição do stent quando o hematoma reabsorve), e a maioria das lesões cicatriza sozinha em semanas. Com paciente estável, sem dor, sem arritmia e com fluxo TIMI 3, a conduta é conservadora, com betabloqueador e monitorização prolongada; a revascularização fica para isquemia persistente, instabilidade ou acometimento do tronco. A heparina deve ser suspensa após o diagnóstico, pelo risco teórico de ampliar o hematoma. A displasia fibromuscular deve ser pesquisada depois.

A) Heparina plena por 7 dias
Errada. A anticoagulação plena deve ser suspensa após o diagnóstico, pelo risco de expandir o hematoma intramural.

B) Revascularização cirúrgica
Errada. Cirurgia fica para dissecção de tronco ou falha da angioplastia em paciente instável, e os enxertos ocluem com a cicatrização da artéria nativa.

C) Tratamento clínico conservador CORRETA
Correta. Dissecção espontânea com fluxo TIMI 3 em paciente estável: tratamento conservador com betabloqueador, porque a lesão cicatriza sozinha.

D) Angioplastia com stent farmacológico ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a conduta na lesão aterosclerótica culpada; na dissecção espontânea com fluxo preservado e paciente estável, a angioplastia traz mais complicação que benefício.

Para levar. Dissecção espontânea de coronária (mulher jovem, periparto, estreitamento longo e liso): conservador se estável com fluxo preservado; angioplastia só com isquemia persistente ou instabilidade.

ESC 2023 (acute coronary syndromes); AHA Scientific Statement 2018 e ESC ACCA position paper 2018 sobre dissecção espontânea de coronária

---

25

Pneumologia · Derrame com espessamento pleural nodular e duas citologias negativas: biópsia por toracoscopia no suspeito de mesotelioma

Negativo no meio

Gabarito B

Homem de 71 anos, aposentado de um estaleiro naval, tem há 3 meses dispneia e dor torácica contínua à direita, com perda de 6 kg. Radiografia: derrame pleural direito moderado. Duas toracocenteses: exsudato linfocítico, ADA 22 U/L, glicose 70 mg/dL e citologia oncótica negativa nas duas. Teste rápido molecular para tuberculose no líquido: negativo. TC de tórax com contraste: espessamento pleural nodular e circunferencial de 1,5 cm à direita, envolvendo a pleura mediastinal, sem massa pulmonar; placas pleurais calcificadas bilaterais. Não há linfonodomegalias. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

espessamento pleural nodular e circunferencial de 1,5 cm à direita, envolvendo a pleura mediastinal

Resolução. As duas citologias negativas, postas no meio do caso, parecem tranquilizar ou convidar a repetir. Mas a exposição ao asbesto (estaleiro, placas pleurais calcificadas), a dor torácica contínua e o espessamento pleural nodular, circunferencial, acima de 1 cm e envolvendo a pleura mediastinal são os critérios tomográficos de malignidade pleural, e a hipótese principal é mesotelioma. A citologia tem baixa sensibilidade para mesotelioma (em torno de 30%), e uma terceira amostra quase não acrescenta depois de duas negativas. O exame indicado é a biópsia pleural com amostra ampla, por toracoscopia (que permite também pleurodese) ou guiada por imagem no espessamento, com imuno-histoquímica. PET serve para estadiar depois do diagnóstico.

A) PET-CT de corpo inteiro
Errada. PET-CT estadia e orienta biópsia, mas não dá o diagnóstico histológico; vem depois.

B) Biópsia pleural por toracoscopia CORRETA
Correta. Suspeita de mesotelioma com citologias negativas: biópsia pleural por toracoscopia, com imuno-histoquímica.

C) Terceira citologia do líquido pleural ARMADILHA
Errada. Uma terceira citologia acrescenta pouco depois de duas negativas, sobretudo no mesotelioma; seria aceitável na suspeita de metástase de adenocarcinoma sem espessamento.

D) Broncoscopia com lavado broncoalveolar
Errada. Não há lesão endobrônquica nem massa; broncoscopia caberia com hemoptise ou atelectasia.

Para levar. Derrame com espessamento pleural nodular, circunferencial, acima de 1 cm ou mediastinal, e exposição ao asbesto: biópsia pleural (toracoscopia), porque a citologia falha no mesotelioma.

BTS Guideline for Pleural Disease 2023; ERS/ESTS/EACTS/ESTRO Guidelines for Malignant Pleural Mesothelioma 2020.

---

26 Infectologia · Mordida de serpente sem fosseta loreal com edema e equimose e coagulação normal: sem soro

Omissão **Gabarito B**

Homem de 28 anos, estudante de biologia, foi mordido na mão esquerda há 3 horas ao manusear uma serpente verde, de cerca de 1 metro, que capturou e trouxe ao PS; a mordida foi prolongada. O plantonista verifica que o animal não tem fosseta loreal, tem pupila redonda e cauda que afina gradualmente. Exame: edema doloroso no dorso da mão até o punho, equimose discreta local, sem bolhas, sem sangramento sistêmico, sem ptose. PA 124 x 78 mmHg, FC 88 bpm. Tempo de coagulação de 8 minutos (referência: até 10 minutos), repetido após 6 horas: 9 minutos. Plaquetas 230.000/mm³, CK 180 U/L. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE
repetido após 6 horas: 9 minutos

Resolução. Edema doloroso e equimose após mordida de serpente parecem o acidente botrópico leve, e a resposta automática é soro. Mas o animal foi trazido e não tem fosseta loreal, presente em todas as serpentes peçonhentas do Brasil, com exceção da coral; serpente verde, de pupila redonda e cauda que afina gradualmente, é a cobra-verde (Philodryas), opistóglifa, que, numa mordida prolongada, inocula secreção capaz de causar edema, dor e equimose locais, mas não coagulopatia. O tempo de coagulação normal na chegada e após 6 horas confirma a ausência de envenenamento botrópico. Não há soro específico, e o

antibotrópico não está indicado: a conduta é analgesia, elevação do membro, limpeza local, profilaxia do tétano conforme a vacinação e observação.

A) Soro antibotrópico, 4 ampolas ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria o soro do botrópico leve; sem fosseta loreal e com coagulação normal repetida, não há envenenamento botrópico.

B) Analgesia, elevação e observação CORRETA
Correta. Mordida de Philodryas: tratamento sintomático e observação, sem soro.

C) Soro antibotrópico-laquético
Errada. O antibotrópico-laquético é para acidente laquético ou dúvida entre os dois, com síndrome vagal e coagulopatia, ausentes.

D) Soro antibotrópico, 12 ampolas
Errada. Doze ampolas são do botrópico grave, com sangramento sistêmico, choque ou insuficiência renal.

Para levar. Edema e equimose após mordida não bastam para soro: sem fosseta loreal e com tempo de coagulação normal repetido, é serpente sem indicação de soroterapia (como Philodryas) e o tratamento é sintomático.

Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde, 6ª ed. (2023); Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos (MS/Funasa, 2001).

27

Gastroenterologia · Colite colagenosa em idosa que iniciou medicação para pirose: budesonida e retirada do inibidor de bomba

Droga a deduzir | Gabarito A

Mulher de 68 anos tem há 3 meses diarreia aquosa, 6 a 8 evacuações ao dia, inclusive à noite, com urgência, sem sangue, sem febre e com perda de 3 kg. Começou, 2 meses antes da diarreia, um comprimido diário em jejum para pirose, que mantém; usa também sertralina há 6 anos e losartana. Exames: hemograma, PCR, TSH, eletrólitos e antitransglutaminase IgA (com IgA total normal) normais; coproparasitológico e toxina de Clostridioides difficile negativos; calprotectina fecal de 180 mcg/g. Colonoscopia com íleo e mucosa colônica macroscopicamente normais; as biópsias seriadas mostram banda de colágeno subepitelial de 18 micrômetros com aumento de linfócitos na lâmina própria. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Começou, 2 meses antes da diarreia, um comprimido diário em jejum para pirose

Resolução. Colonoscopia macroscopicamente normal com colite à histologia faz pensar em tratamento de doença inflamatória intestinal, e a mesalazina é a droga anti-inflamatória que vem à cabeça, somada à suspeita sobre o antidepressivo. Mas a banda de colágeno subepitelial acima de 10 micrômetros define colite colagenosa, uma colite microscópica, e nela a budesonida oral é o único tratamento de indução com eficácia comprovada (mesalazina e bismuto são inferiores). O caso pede ainda deduzir a droga: comprimido diário em jejum para pirose, iniciado meses antes da diarreia, é um inibidor de bomba de prótons, um dos principais desencadeantes de colite microscópica (com AINE, sertralina e outros ISRS), e sua retirada faz parte do tratamento. A sertralina, usada há 6 anos sem diarreia, é suspeita menor. Prednisona tem mais efeitos e menos resposta, e loperamida isolada é para sintomas leves.

A) Budesonida oral e suspender o IBP CORRETA

Correta. Colite colagenosa: budesonida é a indução de escolha, e o IBP iniciado antes da diarreia é desencadeante a retirar.

B) Mesalazina oral e suspender a sertralina ARMADILHA

Errada. A mesalazina é inferior à budesonida na colite microscópica, e a sertralina, usada há 6 anos sem diarreia, é suspeita menor que a droga iniciada 2 meses antes dos sintomas.

C) Prednisona oral e suspender o IBP

Errada. A retirada do IBP está certa, mas o corticoide sistêmico tem resposta menor e mais efeitos adversos que a budesonida na colite microscópica.

D) Loperamida e manter as medicações

Errada. Antidiarreico isolado serve a sintomas leves; aqui há diarreia noturna, perda de peso e uma droga desencadeante mantida.

Para levar. Colite microscópica: budesonida oral para indução e retirada de drogas desencadeantes (IBP, AINE, ISRS, estatinas).

AGA Institute Guideline on the Medical Management of Microscopic Colitis (2016); European Microscopic Colitis Group/UEG Guidelines (2021)

28

Nefrologia · Hiperuricemia assintomática na DRC estágio 3a · não iniciar hipouricemiante para proteger o rim

Omissão **Gabarito D**

Homem de 54 anos, com hipertensão e doença renal crônica (TFGe de 52 mL/min/1,73 m², albuminúria de 40 mg/g), em uso de losartana e anlodipino, traz ácido úrico de 9,8 mg/dL em duas dosagens. Nunca teve artrite, tofos ou cólica renal; ultrassom renal sem cálculos. Não usa diurético nem AAS. Bebe cerveja nos fins de semana e consome refrigerante adoçado diariamente. Pergunta se deve tratar o ácido úrico alto para proteger o rim. Além da orientação dietética, a conduta mais adequada quanto ao ácido úrico é:

O DADO QUE DECIDE

Nunca teve artrite, tofos ou cólica renal

Resolução. A pergunta do paciente e a DRC formam o rótulo que puxa ao tratamento: o ácido úrico se associa à progressão da doença renal em estudos observacionais, e o alopurinol em dose baixa com titulação parece prudente. Mas os ensaios randomizados (CKD-FIX e PERL) não mostraram que reduzir o ácido úrico com alopurinol retarde a perda de filtração, e a KDIGO 2024 sugere não usar hipouricemiante para esse fim na hiperuricemia assintomática. O ACR também recomenda não tratar quem nunca teve gota, tofos ou nefrolitíase. O que cabe é a mudança de estilo de vida (reduzir cerveja e frutose), e o losartana, que já está em uso, tem leve efeito uricosúrico. Tratar o número sem doença é fazer mais do que o caso pede.

A) Alopurinol 100 mg/dia com titulação ARMADILHA

Errada. Seria a conduta ao iniciar hipouricemiante na gota com indicação (crises frequentes, tofos, dano radiográfico), com titulação pela DRC; sem gota, não há indicação.

B) Febuxostate 40 mg/dia

Errada. O febuxostate é alternativa ao alopurinol na gota; na hiperuricemia assintomática também não está indicado.

C) Alopurinol com colchicina profilática

Errada. A profilaxia com colchicina acompanha o início do hipouricemiante na gota, para evitar crise; sem gota, nem um nem outro.

D) Não iniciar hipouricemiante CORRETA

Correta. Sem artrite, tofos ou litíase, hiperuricemia assintomática não se trata com droga, mesmo na DRC.

Para levar. Hiperuricemia assintomática, mesmo com DRC, não se trata com hipouricemiante: os ensaios (CKD-FIX, PERL) não mostraram proteção renal. Tratar quem tem gota, tofo ou litíase.

KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD; FitzGerald JD et al. 2020 ACR Guideline for the Management of Gout; CKD-FIX (NEJM 2020) e PERL (NEJM 2020).

29

Hematologia · Trombocitose de 712.000 com ferropenia grave por menorragia: repor ferro e repetir, antes de pesquisar neoplasia mieloproliferativa

Omissão **Gabarito B**

Mulher de 39 anos, com miomas uterinos e menorragia há 2 anos, queixa-se de cansaço. Hb 9,2 g/dL, VCM 69 fL, RDW 19%, leucócitos 7.800/mm³ com diferencial normal, plaquetas 712.000/mm³. Ferritina 5 ng/mL, saturação de transferrina 4%, PCR normal. Sem esplenomegalia, sem trombose prévia, sem eritromelalgia, sem cefaleia ou alterações visuais. Hemograma de 3 anos atrás, antes da menorragia, com plaquetas de 280.000/mm³. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

Ferritina 5 ng/mL

Resolução. Plaquetas acima de 450.000 levantam a trombocitemia essencial, e o reflexo é pedir o painel molecular. Mas a trombocitose reativa responde pela grande maioria dos casos, e a ferropenia é uma das causas mais frequentes: a deficiência de ferro estimula a megacariopoese (a eritropoetina elevada e a própria carência aumentam a produção de plaquetas). Aqui há ferropenia grave e comprovada (ferritina 5, saturação 4%), causa evidente (menorragia), contagem normal antes da perda e nenhum sinal de neoplasia mieloproliferativa (baço, leucocitose, trombose). O passo é tratar a ferropenia (e a menorragia) e repetir o hemograma: as plaquetas costumam normalizar em semanas. Só se a trombocitose persistir com o ferro reposto entra a pesquisa de JAK2, CALR e MPL. Citorredução e biópsia são passos de quem já tem o diagnóstico de neoplasia.

A) Pesquisa de JAK2, CALR e MPL ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria o próximo passo com trombocitose persistente após corrigir a ferropenia, ou sem causa reativa aparente.

B) Repor ferro e repetir hemograma CORRETA

Correta. Trombocitose com ferropenia grave e causa evidente é reativa até prova em contrário: tratar a carência e recontar.

C) AAS e hidroxiureia
Errada. Citorredução é para trombocitemia essencial de alto risco, diagnóstico que não existe aqui.

D) Biópsia de medula óssea
Errada. A biópsia entra só depois de afastar causa reativa e quando a suspeita de neoplasia persiste.

Para levar. Trombocitose com ferropenia é reativa até repor o ferro: tratar e repetir o hemograma antes de pedir JAK2, CALR e MPL.

BSH 2010/2014 Guideline for investigation and management of adults with essential thrombocythaemia (Harrison et al.); Bleeker & Hogan, Thrombocytosis: diagnostic evaluation, Thrombosis 2011.

---

30 Neurologia · Lesão anelar em tabagista com nódulo pulmonar e extração dentária: restrição à difusão central decide abscesso

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 61 anos, tabagista de 45 maços-ano, foi submetido há 3 semanas à extração de dois molares inferiores com abscesso periapical. Há 10 dias tem cefaleia progressiva e, há 2 dias, fraqueza na mão esquerda; teve uma crise focal motora hoje. Afebril, PA 142/84 mmHg. Hemiparesia esquerda grau 4, sem rigidez de nuca, fundo de olho sem papiledema. Leucócitos 11.800/mm³, PCR 3,2 mg/dL. TC de tórax: nódulo espiculado de 1,8 cm no lobo superior direito. RM de encéfalo: lesão frontoparietal direita de 3,2 cm com realce anelar de parede fina e regular, edema perilesional e restrição à difusão no centro da lesão. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

restrição à difusão no centro da lesão

Resolução. O nódulo espiculado num tabagista pesado é verdadeiro e provavelmente é câncer, e lesão cerebral anelar nesse contexto parece metástase: dexametasona e biópsia do pulmão. A ausência de febre reforça o engano (metade dos abscessos cerebrais é afebril). O dado que separa as duas é a difusão: o pus viscoso do abscesso restringe a difusão no centro, enquanto a necrose tumoral não restringe. A parede fina e regular e a porta de entrada (extração de molar com abscesso periapical há 3 semanas) completam o quadro. Abscesso maior que 2,5 cm pede aspiração estereotáxica (diagnóstica e terapêutica) e antibiótico empírico cobrindo estreptococos e anaeróbios orais (ceftriaxona com metronidazol). Punção lombar é contraindicada pelo efeito de massa e pouco rende.

A) Aspiração estereotáxica e antibiótico CORRETA
Correta. Lesão anelar com restrição central à difusão e foco dentário: abscesso; acima de 2,5 cm, aspiração estereotáxica e antibiótico para flora oral (ceftriaxona com metronidazol).

B) Dexametasona e radioterapia de crânio total
Errada. Seria conduta em metástases múltiplas já confirmadas; aqui a lesão é única, com difusão de abscesso, e não há diagnóstico histológico.

C) Punção lombar com cultura antes do antibiótico
Errada. Lesão com efeito de massa contraindica punção lombar (risco de herniação), e a cultura do líquor raramente identifica o agente.

D) Dexametasona e biópsia do nódulo pulmonar ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria o caminho para metástase com necrose sem restrição à difusão; aqui o abscesso pede drenagem e antibiótico, e corticoide sem cobertura antibiótica só atrasa o tratamento (fica reservado ao edema com efeito de massa grave).

Para levar. Lesão anelar: restrição à difusão no centro é abscesso (pus), não metástase; acima de 2,5 cm, aspiração e antibiótico.

ESCMID Guideline on diagnosis and treatment of brain abscess 2024 (Bodilsen et al.); Brouwer et al., Brain abscess (NEJM 2014).

---

31 Reumatologia · Antes de inibidor de JAK: vacina recombinante contra herpes-zóster

Qualificador **Gabarito D**

Homem de 52 anos, com artrite reumatoide, vai iniciar tofacitinibe associado ao metotrexato. Teve varicela na infância e nunca recebeu vacina contra herpes-zóster. Para a prevenção do herpes-zóster, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

vai iniciar tofacitinibe associado ao metotrexato

Resolução. Os inibidores de JAK aumentam de forma marcada o risco de herpes-zóster, mais ainda com metotrexato ou corticoide associado, e a prevenção deve ser feita antes de iniciá-los. A vacina atenuada parece suficiente se dada semanas antes, mas tem eficácia menor, é de vírus vivo (risco se a imunossupressão começar cedo) e foi substituída. A vacina recombinante adjuvada, de subunidade e não viva, em duas doses com intervalo de 2 a 6 meses, é recomendada a partir dos 18 anos para quem usa ou vai usar imunossupressor, e pode ser dada mesmo durante o tratamento. Profilaxia antiviral contínua não é recomendada de rotina.

A) Valaciclovir profilático contínuo

Errada. Antiviral contínuo não é recomendado de rotina; reserva-se a situações como transplante de medula.

B) Vacina atenuada 4 semanas antes ARMADILHA

Errada. Vírus vivo, menos eficaz e substituída; não é a escolha para quem vai usar imunossupressor.

C) Nenhuma vacina, pela imunossupressão

Errada. A recombinante não é viva e pode ser dada em imunossuprimidos, que são justamente os mais beneficiados.

D) Vacina recombinante adjuvada, duas doses CORRETA

Correta. Não viva, eficaz em imunossuprimidos e indicada a partir dos 18 anos para quem usa ou vai usar JAK.

Para levar. Antes de inibidor de JAK (e em qualquer imunossuprimido a partir dos 18 anos), vacina recombinante adjuvada contra zóster em duas doses.

2022 American College of Rheumatology Guideline for Vaccinations in Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases.

---

32 Endocrinologia · Esteatose metabólica com ALT pouco mais de duas vezes o normal após infarto: reintroduzir a estatina de alta intensidade, sem esperar as enzimas normalizarem

Limiar **Gabarito A**

Homem de 57 anos, com diabetes tipo 2 há 8 anos em metformina e empagliflozina (HbA1c 7,2%), hipertensão e IMC de 32 kg/m², teve infarto sem supradesnivelamento de ST há 3 meses, tratado com angioplastia. Recebeu atorvastatina 80 mg/dia na alta, mas outro médico a suspendeu há 6 semanas ao ver transaminases elevadas e esteatose moderada na ultrassonografia, orientando aguardar a normalização. Antes da estatina, a ALT já era de 88 U/L. Consome uma dose de álcool por semana; HBsAg e anti-HCV negativos. Sem estigmas de hepatopatia, baço não palpável. Exames atuais: AST 58 U/L (VR até 40), ALT 96 U/L (VR até 41), bilirrubinas e albumina normais, plaquetas 245.000/mm³, LDL 148 mg/dL. Elastografia hepática transitória: 6,1 kPa. Em relação ao tratamento hipolipemiante, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

ALT 96 U/L (VR até 41)

Resolução. Esteatose com transaminases elevadas é um rótulo verdadeiro que assusta e faz suspender a estatina, e quem percebe que o paciente precisa de algum hipolipemiante tende a escolher o meio-termo que parece poupar o fígado. O limiar que decide é o das transaminases: estatina só se evita ou se suspende com ALT acima de 3 vezes o limite superior, na cirrose descompensada ou na insuficiência hepática aguda. Aqui a ALT está em pouco mais de 2 vezes, já estava alta antes da droga (ou seja, é da doença hepática metabólica, e não da estatina) e a elastografia de 6,1 kPa afasta fibrose avançada. A doença hepática gordurosa metabólica não contraindica estatina; ela é segura nesses pacientes e o risco que mata este homem é cardiovascular (infarto há 3 meses, diabetes). A conduta é reintroduzir a estatina de alta intensidade, repetir as enzimas em 6 a 12 semanas e, se o LDL seguir fora da meta, associar ezetimiba depois, e não no lugar dela.

A) Reintroduzir atorvastatina 80 mg/dia CORRETA

Correta. ALT abaixo de 3 vezes o limite superior, já elevada antes da estatina, sem fibrose avançada, em paciente de muito alto risco após infarto: reintroduzir a estatina de alta intensidade.

B) Ezetimiba isolada até normalizar a ALT ARMADILHA

Errada. É a armadilha: ezetimiba isolada reduz o LDL em cerca de 20% e não substitui a estatina na prevenção secundária; seria opção só com intolerância real e documentada às estatinas.

C) Aguardar a ALT normalizar, sem droga

Errada. Seria a conduta com ALT acima de 3 vezes o limite superior ou com hepatopatia descompensada; esperar deixa sem tratamento um paciente no período de maior risco após o infarto.

D) Rosuvastatina 5 mg em dias alternados

Errada. Dose baixa intermitente é estratégia para intolerância muscular às estatinas; não há intolerância aqui, e a dose não alcança a redução de LDL que a prevenção secundária exige.

Para levar. Esteatose metabólica não contraindica estatina: só ALT acima de 3 vezes o limite superior, cirrose descompensada ou insuficiência hepática aguda justificam suspendê-la; na prevenção secundária, mantenha a alta intensidade.

AASLD 2023 (Practice guidance on the clinical assessment and management of NAFLD); EASL-EASD-EASO 2024 (Clinical practice guidelines on MASLD); ESC/EAS 2019 (Guidelines for the management of dyslipidaemias).

---

33 Cardiologia · Estenose aórtica grave 'assintomática' com teste ergométrico positivo: intervenção, e troca cirúrgica abaixo de 65 anos

Grade X / Y **Gabarito A**

Homem de 62 anos, engenheiro, é encaminhado por sopro encontrado em exame de rotina. Nega dispneia, angina ou síncope, mas conta que 'diminuiu o ritmo' das caminhadas no último ano, o que atribui à idade. Tem dislipidemia controlada e nenhuma outra comorbidade; risco cirúrgico STS de 1,2%. Exame: PA 132×80 mmHg, pulso carotídeo parvus et tardus, sopro sistólico ejetivo 4+/6+ em foco aórtico com frêmito, B2 única. Ecocardiograma: valva aórtica tricúspide calcificada, velocidade máxima de 4,4 m/s, gradiente médio de 48 mmHg, área valvar de 0,7 cm², fração de ejeção de 63%. Teste ergométrico: interrompido aos 4 minutos do protocolo de Bruce por dispneia desproporcional e tontura, com queda da PA sistólica de 150 para 128 mmHg. A conduta e a modalidade de tratamento são, respectivamente:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *interrompido aos 4 minutos do protocolo de Bruce por dispneia desproporcional e tontura, com queda da PA sistólica de 150 para 128 mmHg*

Resolução. O paciente se declara assintomático, e a estenose grave assintomática com fração de ejeção normal é, por tradição, seguida com eco seriado: esse é o rótulo que leva à armadilha. Mas ele reduziu a atividade sem perceber, que é o modo como o idoso esconde o sintoma, e o teste ergométrico desmascarou: dispneia e tontura em carga baixa e queda da PA sistólica no esforço. Sintoma no teste é indicação classe I de intervenção, e a queda de PA de mais de 20 mmHg também a sustenta; a estenose passa a ser tratada como sintomática. A segunda metade é a modalidade: com 62 anos, valva tricúspide e risco cirúrgico baixo, a troca valvar cirúrgica é preferida, porque a durabilidade da bioprótese transcateter em quem tem mais de 20 anos de expectativa de vida ainda não está estabelecida e a prótese mecânica é opção. O implante transcateter é preferido acima de 70 a 75 anos (conforme a diretriz) ou no risco cirúrgico alto.

A) Intervenção agora / troca valvar cirúrgica CORRETA
Correta. Sintoma e queda da PA no teste ergométrico indicam intervenção, e aos 62 anos, com risco baixo, a troca cirúrgica é a modalidade preferida.

B) Intervenção agora / implante transcateter
Errada. Acerta a indicação, mas o implante transcateter é preferido em idosos (acima de 70 a 75 anos) ou de risco cirúrgico alto, e não aos 62 com STS de 1,2%.

C) Reavaliar em 6 meses / troca valvar cirúrgica ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Reavaliar seria a conduta com teste ergométrico normal; aqui o teste mostrou sintoma e queda da PA, e a estenose deixa de ser assintomática.

D) Reavaliar em 6 meses / implante transcateter
Errada. Erra as duas metades: há indicação de intervenção já, e aos 62 anos com risco baixo a modalidade é cirúrgica.

Para levar. Estenose aórtica grave 'assintomática': fazer teste ergométrico; sintoma ou queda da PA no esforço indicam intervenção; abaixo de 65 a 70 anos e com risco baixo, troca cirúrgica.

Atualização das Diretrizes Brasileiras de Valvopatias 2020 (SBC); ESC/EACTS 2025 (valvular heart disease); ACC/AHA 2020 (valvular heart disease)

---

34 Hepatologia · Colangite esclerosante recém-diagnosticada em retocolite: colonoscopia anual a partir do diagnóstico, sem esperar 8 anos

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 24 anos tem retocolite ulcerativa extensa diagnosticada há 2 anos, em remissão clínica com mesalazina, com última colonoscopia há 10 meses mostrando mucosa cicatrizada. Na rotina, fosfatase alcalina de 380 U/L e GGT de 420 U/L persistentes há 6 meses, com bilirrubinas normais e assintomático. A colangiorressonância mostra estenoses curtas multifocais intercaladas com segmentos dilatados nas vias intra e extra-hepáticas, sem estenose dominante; antimitocôndria negativo e IgG4 sérica normal; elastografia de 7 kPa. Firmado o diagnóstico de colangite esclerosante primária, quanto à vigilância colonoscópica do câncer colorretal, a periodicidade e o início são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Firmado o diagnóstico de colangite esclerosante primária

Resolução. A regra conhecida para doença inflamatória intestinal é iniciar a vigilância 8 anos após o início dos sintomas, e com retocolite de 2 anos parece cedo demais para colonoscopia. Mas a colangite esclerosante primária é a exceção: aumenta várias vezes o risco de displasia e câncer colorretal, com predomínio no cólon direito, e o risco começa cedo. Por isso a vigilância passa a ser anual (com cromoendoscopia e biópsias), iniciada no momento do diagnóstico de CEP, independentemente do tempo de colite. A remissão clínica e a mucosa cicatrizada não mudam essa regra. O ácido ursodesoxicólico em dose alta não é recomendado como quimioprevenção (aumentou eventos em dose de 28 a 30 mg/kg).

A) A cada 3 anos / a partir de agora
Errada. O início está certo, mas intervalo de 3 anos serve à colite extensa sem fatores de alto risco; com CEP o intervalo é anual.

B) A cada 3 anos / após 8 anos de colite
Errada nas duas metades: seria a regra da retocolite extensa de risco intermediário, sem CEP.

C) Anual / após 8 anos de colite ARMADILHA
Errada. O intervalo anual está certo, mas a CEP antecipa o início para o momento do diagnóstico, sem esperar 8 anos.

D) Anual / a partir de agora CORRETA
Correta. CEP com doença inflamatória intestinal: colonoscopia anual a partir do diagnóstico da CEP.

Para levar. Doença inflamatória intestinal com colangite esclerosante primária: colonoscopia de vigilância anual desde o diagnóstico da CEP, sem esperar os 8 anos.

AASLD Practice Guidance on primary sclerosing cholangitis and cholangiocarcinoma (2023); ACG Clinical Guideline: Primary Sclerosing Cholangitis (2015); ECCO Guidelines on Inflammatory Bowel Disease and Malignancies (2023)

---

35 Infectologia · Mononucleose infecciosa: a indicação isolada de corticoide

Qualificador **Gabarito A**

Na mononucleose infecciosa pelo vírus Epstein-Barr em adulto jovem, o corticoide sistêmico está indicado, isoladamente, quando há:

O DADO QUE DECIDE

isoladamente

Resolução. Odinofagia intensa e amígdalas cobertas de exsudato fazem o corticoide parecer alívio razoável, e é a indicação que mais se vê na prática. Mas na mononucleose não complicada o corticoide não traz benefício consistente e pode prolongar a replicação viral; as indicações aceitas são complicações graves: obstrução iminente de vias aéreas pela hipertrofia linfoide (a mais clara, isoladamente suficiente), anemia hemolítica grave, trombocitopenia grave e, em discussão, complicações neurológicas e miocardite. Esplenomegalia muda a orientação de atividade física (evitar esporte de contato), não o tratamento, e a proporção de linfócitos atípicos não tem valor prognóstico para isso.

A) Obstrução iminente de vias aéreas CORRETA
Correta. Obstrução iminente de vias aéreas por hipertrofia tonsilar é a indicação mais clara de corticoide na mononucleose.

B) Esplenomegalia acima de 4 cm
Errada. Esplenomegalia indica evitar esportes de contato pelo risco de ruptura, não corticoide.

C) Odinofagia com exsudato extenso ARMADILHA
Errada. É a armadilha: dor de garganta e exsudato, por mais intensos, não indicam corticoide na doença não complicada.

D) Linfócitos atípicos acima de 20%
Errada. A contagem de linfócitos atípicos é diagnóstica, sem papel na decisão terapêutica.

Para levar. Mononucleose: tratamento de suporte; corticoide só para obstrução de vias aéreas, hemólise ou trombocitopenia graves.

Harrison's Principles of Internal Medicine, 21ª ed. (2022), Epstein-Barr Virus Infections; Mandell, Douglas and Bennett, 9ª ed. (2020).

---

36 Terapia intensiva · Extubação do DPOC hipercápnico que passou no teste de respiração espontânea: VNI preventiva imediata

Limiar **Gabarito A**

Homem de 70 anos, com DPOC (VEF1 35%) e insuficiência cardíaca, está intubado há 5 dias por exacerbação com acidose respiratória (pH inicial 7,18, PaCO2 92 mmHg). Hoje, sem sedação, está acordado e cooperativo, tem tosse eficaz e pouca secreção, sem vasopressor. Passou no teste de respiração espontânea de 30 minutos em pressão de suporte de 7 cmH2O: FR 24 irpm, SpO2 93% com FiO2 de 30%, sem desconforto. Gasometria ao fim do teste: pH 7,37, PaCO2 56 mmHg, HCO3 32 mEq/L. A equipe discute o que fazer agora. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

pH 7,37, PaCO2 56 mmHg

Resolução. Passou no teste de respiração espontânea, está acordado e tosse bem: o reflexo é extubar para oxigênio simples. Mas ele é paciente de alto risco de falha de extubação (DPOC, insuficiência cardíaca, idade acima de 65 anos) e está hipercápnico ao fim do teste, com PaCO2 acima de 45 mmHg. Para esse grupo, a diretriz da ERS/ATS recomenda extubar e colocar em ventilação não invasiva imediatamente, de forma preventiva, o que reduz reintubação e, nos hipercápnicos, mortalidade. Manter intubado não se justifica em quem passou no teste, e a hipercapnia compensada (pH normal, bicarbonato alto) não é falha do teste. VNI de resgate, iniciada só depois que a insuficiência respiratória pós-extubação se instala, não tem o mesmo benefício.

A) Extubar e iniciar VNI imediatamente CORRETA
Correta. Alto risco de falha e hipercapnia ao fim do teste: extubar direto para VNI preventiva.

B) Extubar para cateter nasal de oxigênio ARMADILHA
Errada. É a conduta no paciente de baixo risco, sem hipercapnia; aqui aumenta a chance de reintubação.

C) Manter intubado e repetir o teste amanhã
Errada. Hipercapnia com pH normal não é falha do teste; adiar prolonga a ventilação sem benefício.

D) Indicar traqueostomia precoce
Errada. Traqueostomia é para desmame prolongado, após falhas repetidas, não para quem passou no primeiro teste.

Para levar. Paciente que passou no teste de respiração espontânea mas é de alto risco, sobretudo hipercápnico (PaCO2 acima de 45): extubar direto para VNI preventiva, e não para oxigênio simples.

ERS/ATS Clinical Practice Guidelines: Noninvasive Ventilation for Acute Respiratory Failure 2017; ATS/CHEST Liberation from Mechanical Ventilation Guideline 2017.

---

37 Hematologia · Transfusão após sobrecarga circulatória prévia, em cardiopata com Hb 6,4: uma unidade, infusão lenta e diurético

Grade X / Y — Gabarito A

Mulher de 84 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (FE 30%) e doença renal crônica estágio 4, tem anemia por doença crônica e ferropenia, com Hb de 6,4 g/dL, dispneia aos pequenos esforços e tontura. Há 2 meses, em outra internação, teve sobrecarga circulatória associada à transfusão confirmada, após 2 concentrados de hemácias infundidos em 3 horas. Hoje está euvolêmica: PA 128/70 mmHg, FC 92 bpm, sem estertores, sem turgência jugular, SpO2 95% em ar ambiente. Peso de 52 kg. Para a transfusão de hoje, o número de unidades e o modo de infusão mais adequados são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Há 2 meses, em outra internação, teve sobrecarga circulatória associada à transfusão confirmada

Resolução. Com Hb de 6,4, a meta de 7 a 8 g/dL parece pedir duas unidades, e o apressado acerta a velocidade e erra o volume. A transfusão está indicada (Hb abaixo de 7 com sintomas), mas a sobrecarga circulatória prévia, a FE de 30%, a DRC avançada, a idade e o peso baixo são os principais fatores de risco de recorrência. A recomendação é transfundir uma unidade por vez e reavaliar clínica e Hb antes da seguinte

(em 52 kg, uma unidade eleva cerca de 1,5 g/dL), com infusão lenta (cerca de 1 mL/kg/h, sem passar de 4 horas por bolsa), diurético antes ou durante quando há risco e monitorização dos sinais e do balanço. Infusão padrão em 2 horas foi justamente o que causou a sobrecarga anterior.

A) Uma unidade / infusão lenta com diurético CORRETA
Correta. Uma unidade por vez com reavaliação, infusão lenta e diurético profilático, porque ela já teve sobrecarga e tem IC grave e DRC.

B) Duas unidades / infusão lenta com diurético ARMADILHA
Errada, é a armadilha. A infusão está certa, mas duas unidades de uma vez repetem o volume que causou a sobrecarga; a segunda só após reavaliar.

C) Uma unidade / infusão padrão em 2 horas
Errada na segunda metade. Uma unidade é o certo, mas a velocidade padrão é o que precipitou a reação anterior.

D) Duas unidades / infusão padrão em 2 horas
Errada nas duas metades. Repete exatamente o esquema da sobrecarga circulatória anterior.

Para levar. Quem já teve sobrecarga circulatória transfusional recebe uma unidade por vez, em infusão lenta (cerca de 1 mL/kg/h), com diurético e reavaliação antes da próxima.

BSH 2017/2023 Guidelines on the administration of blood components (Robinson et al.); ISBT 2018 TACO surveillance criteria; Ministério da Saúde, Guia para uso de hemocomponentes, 2015.

38

Nefrologia · Creatinina subindo no transplantado renal após macrolídeo, com história de doses esquecidas · nível de tacrolimo antes da biópsia

Rótulo verdadeiro

Gabarito C

Homem de 46 anos, transplantado renal há 9 meses, usa tacrolimo, micofenolato e prednisona 5 mg/dia, com creatinina basal de 1,2 mg/dL. Há 10 dias iniciou claritromicina para sinusite. Conta que esqueceu algumas doses do micofenolato no mês passado. Hoje: creatinina 1,9 mg/dL, potássio 5,7 mEq/L, magnésio 1,3 mg/dL, glicose 210 mg/dL; tremor fino de mãos, PA 158/94 mmHg, diurese preservada, enxerto indolor, afebril. EAS sem hematúria e sem proteinúria significativa; ultrassom com Doppler do enxerto sem hidronefrose e com fluxo normal. O exame mais adequado neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

Há 10 dias iniciou claritromicina

Resolução. Doses esquecidas do imunossupressor são o rótulo verdadeiro que puxa para rejeição e, com ela, para a biópsia do enxerto. Mas o caso está cheio de sinais de excesso, e não de falta, de inibidor de calcineurina: tremor, hipercalemia, hipomagnesemia, hiperglicemia e hipertensão, tudo começando depois da claritromicina, potente inibidora do CYP3A4, que eleva o nível do tacrolimo várias vezes. A nefrotoxicidade aguda do tacrolimo é hemodinâmica (vasoconstrição da arteríola aferente) e reversível ao ajustar a dose, e o exame simples que a confirma é o nível de vale. Se o nível estiver adequado e a creatinina não voltar, aí a biópsia (e a pesquisa de anticorpos doador-específicos) entram para investigar rejeição. Além disso, o esquecimento foi do micofenolato, que não altera o nível do tacrolimo.

A) Biópsia do enxerto renal ARMADILHA

Errada. É o padrão-ouro para rejeição e o passo seguinte se o nível de tacrolimo estiver na faixa e a disfunção persistir; não é o primeiro com uma interação evidente.

B) PCR para poliomavírus BK no plasma

Errada. Seria pedido na disfunção insidiosa com imunossupressão intensa e sem causa clara, em geral no primeiro ano; aqui a interação explica o quadro.

C) Nível sérico de vale do tacrolimo CORRETA

Correta. Claritromicina inibe o CYP3A4, e tremor, hipercalemia, hipomagnesemia e hiperglicemia sugerem tacrolimo em excesso.

D) Anticorpos anti-HLA específicos do doador

Errada. Faz parte da investigação de rejeição mediada por anticorpo, depois de afastar a causa farmacológica.

Para levar. Creatinina subindo no transplantado em uso de tacrolimo: antes da biópsia, nível de vale, sobretudo após droga que inibe o CYP3A4 (macrolídeo, azólico, diltiazem, verapamil).

KDIGO Clinical Practice Guideline for the Care of Kidney Transplant Recipients (2009).

39

Neurologia · Paciente 'sem responder' ao lado do frasco de clonazepam que olha para cima quando pedido: síndrome do encarceramento por oclusão da basilar

Rótulo verdadeiro

Gabarito B

Homem de 66 anos, hipertenso e com fibrilação atrial sem anticoagulação, foi encontrado pela filha às 7 h caído ao lado da cama, 'sem responder'; ao lado havia um frasco de clonazepam com poucos comprimidos (o número exato é desconhecido). Fora visto bem às 23 h. No pronto-socorro, não fala e não move os membros; está de olhos abertos espontaneamente e, quando solicitado, olha para cima e fecha os olhos, repetindo o comando; não há movimentos horizontais dos olhos. Tetraplegia com Babinski bilateral. PA 178/96 mmHg, FC 104 bpm irregular, SpO2 95%. Glicemia 132 mg/dL, sódio 139 mEq/L. TC de crânio sem lesões agudas. O diagnóstico mais provável é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *quando solicitado, olha para cima e fecha os olhos, repetindo o comando*

Resolução. O frasco de clonazepam é o rótulo que encerra o raciocínio em intoxicação e flumazenil. Mas o paciente não está em coma: está de olhos abertos e obedece a comandos com o olhar vertical e as pálpebras, com tetraplegia, anartria, perda do olhar horizontal e Babinski bilateral. Isso é síndrome do encarceramento, por lesão da base da ponte com tegmento poupado. Benzodiazepínico deprime a consciência e não produz tetraplegia com Babinski e olhar vertical voluntário preservado. Entre as causas do encarceramento, a instalação súbita num paciente com fibrilação atrial sem anticoagulação aponta para oclusão embólica da artéria basilar, e o sódio normal afasta mielinólise. A TC inicial costuma ser normal; o passo seguinte é a angiotomografia, porque a trombectomia na basilar tem benefício até 24 horas do último momento visto bem.

A) Coma por intoxicação por benzodiazepínico ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Intoxicação por benzodiazepínico rebaixa a consciência por inteiro; não deixa o paciente acordado obedecendo com o olhar vertical, nem dá Babinski bilateral.

B) Síndrome do encarceramento por oclusão da basilar CORRETA

Correta. Consciência preservada com tetraplegia, anartria e só olhar vertical e piscar voluntários, em paciente com fibrilação atrial: encarceramento por oclusão da basilar.

C) Estado de mal epiléptico não convulsivo

Errada. Estado de mal não convulsivo rebaixa a consciência e não permite obedecer a comandos de forma consistente.

D) Síndrome do encarceramento por mielinólise pontina

Errada. A mielinólise pontina dá o mesmo encarceramento, mas dias após correção rápida de sódio ou em etilista desnutrido; aqui o sódio é normal e a instalação foi abrupta.

Para levar. Paciente que parece em coma mas olha para cima e pisca sob comando está encarcerado: pense em oclusão da basilar e peça angiotomografia, a trombectomia vale até 24 horas.

AHA/ASA Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke 2019; ATTENTION e BAOCHE (NEJM 2022) para trombectomia na basilar; Plum and Posner's Diagnosis of Stupor and Coma, 5ª ed. (2019).

40

Farmacodermias · SCORTEN na necrólise epidérmica: contar só o que passa do corte, com bicarbonato e glicemia no limite

Limiar **Gabarito B**

Homem de 46 anos, sem neoplasia conhecida, é internado no 1º dia de síndrome de sobreposição Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica atribuída ao sulfametoxazol-trimetoprima, com destacamento epidérmico de 18% da superfície corporal. FC 124 bpm, PA 108 × 64 mmHg. Exames da admissão: ureia 72 mg/dL (nitrogênio ureico 34 mg/dL), bicarbonato sérico 21 mEq/L, glicemia 238 mg/dL, creatinina 1,4 mg/dL. A pontuação do SCORTEN deste paciente é:

O DADO QUE DECIDE

bicarbonato sérico 21 mEq/L, glicemia 238 mg/dL

Resolução. O SCORTEN soma 1 ponto para cada um de sete itens no primeiro dia: idade de 40 anos ou mais, neoplasia, FC de 120 bpm ou mais, destacamento acima de 10% da superfície, nitrogênio ureico acima de 28 mg/dL (cerca de 60 mg/dL de ureia), bicarbonato abaixo de 20 mEq/L e glicemia acima de 252 mg/dL. Este paciente pontua idade (46), FC (124), destacamento (18%) e nitrogênio ureico (34): 4 pontos, mortalidade estimada de cerca de 58%. O bicarbonato de 21 e a glicemia de 238 estão próximos dos cortes, mas não os ultrapassam, e é aí que o apressado soma 5 ou 6. A creatinina não faz parte do escore. A pontuação orienta o nível de cuidado: 2 ou mais justificam unidade de queimados ou terapia intensiva.

A) 3

Errada. Seria a soma de quem esquece a idade de 46 anos, que já pontua a partir de 40.

B) 4 CORRETA

Correta. Idade, FC, destacamento acima de 10% e nitrogênio ureico acima de 28 mg/dL: 4 pontos.

C) 5 ARMADILHA

Errada. Soma um dos itens limítrofes: bicarbonato de 21 não é abaixo de 20, e glicemia de 238 não passa de 252.

D) 6

Errada. Conta os dois itens limítrofes como alterados; nenhum deles ultrapassa o corte.

Para levar. SCORTEN: idade de 40 ou mais, câncer, FC de 120 ou mais, destacamento acima de 10%, nitrogênio ureico acima de 28, bicarbonato abaixo de 20 e glicemia acima de 252; 4 pontos, cerca de 58% de mortalidade.

Bastuji-Garin et al., SCORTEN (J Invest Dermatol, 2000); British Association of Dermatologists guidelines for SJS/TEN in adults (2016).

41

Hepatologia · Insuficiência hepática no terceiro trimestre com hipoglicemia e coagulopatia: esteatose hepática aguda da gestação, e não HELLP

Rótulo verdadeiro

Gabarito A

Primigesta de 27 anos, com 34 semanas, gestação gemelar, procura a maternidade com náuseas, vômitos e dor epigástrica há 5 dias, mal-estar, muita sede e urina abundante, e há 2 dias percebeu os olhos amarelados. Exame: sonolenta, mas orientada, ictérica 2+/4+, PA 142 × 92 mmHg, FC 104 bpm, dor leve em epigástrio, sem edema. Exames: glicemia 52 mg/dL, AST 420 U/L, ALT 380 U/L, bilirrubina total 6,8 mg/dL, INR 2,1, fibrinogênio 110 mg/dL, plaquetas 118.000/mm³, LDH 420 U/L, sem esquizócitos no esfregaço, leucócitos 19.500/mm³, creatinina 1,9 mg/dL, ácido úrico 9,8 mg/dL, proteinúria de fita 1+. Ultrassonografia: fígado discretamente hiperecogênico, sem hematoma subcapsular. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

glicemia 52 mg/dL

Resolução. PA de 142 × 92 com proteinúria e dor epigástrica no terceiro trimestre é rótulo verdadeiro de pré-eclâmpsia, e com transaminases altas e plaquetas abaixo de 150.000 o reflexo é HELLP. Mas HELLP é microangiopatia, com hemólise (LDH acima de 600, esquizócitos), plaquetopenia como achado central e função de síntese preservada até tarde. Aqui o que domina é insuficiência hepática: hipoglicemia de 52, INR de 2,1, fibrinogênio baixo, icterícia, encefalopatia leve, além de leucocitose, lesão renal, ácido úrico alto e polidipsia com poliúria (diabetes insípido transitório), compondo os critérios de Swansea da esteatose aguda da gestação. Gestação gemelar e primiparidade são fatores de risco. Hipertensão leve aparece em até metade dos casos. A conduta é estabilizar (glicose, plasma, crioprecipitado) e interromper a gestação logo.

A) Esteatose hepática aguda da gestação CORRETA

Correta. Hipoglicemia, coagulopatia com fibrinogênio baixo, encefalopatia, leucocitose, lesão renal e poliúria no terceiro trimestre: critérios de Swansea.

B) Síndrome HELLP ARMADILHA

Errada. Daria hemólise com LDH acima de 600 e esquizócitos, plaquetopenia dominante e função de síntese preservada; não explica hipoglicemia nem INR de 2,1.

C) Colestase intra-hepática da gestação

Errada. Causa prurido com ácidos biliares altos e transaminases moderadas, sem insuficiência hepática, hipoglicemia ou coagulopatia.

D) Hepatite viral aguda fulminante

Errada. Pode imitar o quadro, mas não explica poliúria, ácido úrico alto e o contexto do terceiro trimestre de gemelar; a investigação viral é feita, mas não é a hipótese mais provável.

Para levar. Terceiro trimestre com insuficiência hepática: hipoglicemia, INR alto e fibrinogênio baixo apontam esteatose aguda da gestação; HELLP é hemólise com plaquetopenia e síntese preservada.

EASL Clinical Practice Guidelines on the management of liver diseases in pregnancy (2023); ACG Clinical Guideline: Liver Disease and Pregnancy (2016); critérios de Swansea (Ch'ng et al., Gut, 2002)

---

42 Cardiologia · Flutter atrial típico de duração incerta e recorrente: anticoagular antes da cardioversão e ablação do istmo cavotricuspídeo

Cronologia **Gabarito D**

Homem de 68 anos, hipertenso e diabético, sem cardiopatia estrutural, tem palpitações e cansaço há cerca de 10 dias, sem saber precisar o início. Há 8 meses teve episódio igual, revertido com cardioversão elétrica. Exame: PA 136×84 mmHg, FC 150 bpm, regular, sem congestão. ECG: ondas F em dente de serra, negativas em DII, DIII e aVF e positivas em V1, com condução 2:1. Ecocardiograma transtorácico: fração de ejeção de 55% e átrio esquerdo de 42 mm. Creatinina de 1,0 mg/dL. Recusa ecocardiograma transesofágico. Controlada a frequência, a estratégia para restaurar o ritmo e o tratamento de longo prazo do ritmo são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

há cerca de 10 dias, sem saber precisar o início

Resolução. A ideia de que o flutter é 'menos emboligênico' que a fibrilação atrial e de que basta cardioverter leva à armadilha. O risco tromboembólico do flutter é semelhante ao da FA, e as regras são as mesmas: com duração acima de 48 horas ou desconhecida, a cardioversão eletiva exige 3 semanas de anticoagulação efetiva antes (ou ecocardiograma transesofágico sem trombo, que ele recusou) e 4 semanas depois; e a anticoagulação de longo prazo segue o escore de risco (aqui, hipertensão, diabetes e idade: indicada). A segunda metade: no flutter típico, dependente do istmo cavotricuspídeo (ondas F negativas na parede inferior e positivas em V1), recorrente e sintomático, a ablação do istmo é a primeira escolha para controle do ritmo, com sucesso acima de 90%, superior aos antiarrítmicos. A amiodarona contínua expõe a toxicidade de longo prazo sem a mesma eficácia. A ablação não suspende a anticoagulação por si: muitos desenvolvem FA depois.

A) Anticoagular 3 semanas antes / amiodarona contínua

Errada. Acerta a cronologia da cardioversão, mas a amiodarona contínua é inferior à ablação no flutter típico recorrente e expõe a toxicidade de longo prazo.

B) Cardioversão imediata / amiodarona contínua

Errada. Erra as duas metades: duração incerta impede cardioversão sem anticoagulação prévia ou transesofágico, e a amiodarona não é a primeira escolha.

C) Cardioversão imediata / ablação do istmo cavotricuspídeo ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Acerta a ablação, mas cardioverter flutter de duração incerta sem 3 semanas de anticoagulação ou transesofágico expõe a embolia, como na FA.

D) Anticoagular 3 semanas antes / ablação do istmo cavotricuspídeo CORRETA

Correta. Flutter de duração incerta pede 3 semanas de anticoagulação antes da cardioversão, e o flutter típico recorrente tem a ablação do istmo cavotricuspídeo como tratamento de escolha.

Para levar. Flutter atrial segue as regras de anticoagulação da FA (48 horas, 3 semanas antes e 4 depois, escore de risco); flutter típico recorrente: ablação do istmo cavotricuspídeo.

ESC 2019 (supraventricular tachycardia); ESC 2024 (atrial fibrillation); II Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial (SBC 2016)

---

43 Endocrinologia · Diabetes após transplante renal com HbA1c normal: o teste oral decide, porque anemia e transfusão falseiam a HbA1c

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 54 anos, transplantado renal há 5 meses (doador falecido), usa tacrolimo, micofenolato e prednisona 5 mg/dia, com creatinina estável de 1,3 mg/dL. Não tinha diabetes antes do transplante. No 3º mês pós-transplante teve anemia (hemoglobina de 7,8 g/dL), recebeu duas transfusões e iniciou eritropoetina; a hemoglobina atual é de 10,9 g/dL. Assintomático. Exames de rotina: glicemia de jejum de 112 e 118 mg/dL em duas ocasiões e HbA1c de 5,7%. Teste oral com 75 g de glicose, repetido com intervalo de 2 semanas: jejum de 114 e 117 mg/dL, e 2 horas de 236 e 224 mg/dL. Com esses dados, o diagnóstico é:

O DADO QUE DECIDE

2 horas de 236 e 224 mg/dL

Resolução. Glicemia de jejum entre 100 e 125 e HbA1c de 5,7% parecem, juntas, um pré-diabetes tranquilizador. Mas no transplantado a HbA1c no primeiro ano é pouco confiável: anemia, transfusões, eritropoetina e a disfunção renal encurtam ou alteram a sobrevida das hemácias e subestimam a glicemia média. O tacrolimo e o corticoide prejudicam sobretudo a glicemia pós-prandial, que a glicemia de jejum não capta. Por isso o teste oral de 75 g é o exame mais sensível para o diabetes pós-transplante, e 2 horas acima de 200 mg/dL em dois testes fecham o diagnóstico no assintomático. A hiperglicemia dos primeiros dias a semanas após a cirurgia não se rotula como diabetes, mas aos 5 meses, em imunossupressão estável de manutenção, o critério vale.

A) Diabetes pós-transplante CORRETA

Correta. Cinco meses após o transplante, em imunossupressão de manutenção, dois testes orais com 2 horas acima de 200: diabetes pós-transplante, apesar da HbA1c normal.

B) Glicemia de jejum alterada ARMADILHA

Errada. É a armadilha: a glicemia de jejum está na faixa alterada, mas a de 2 horas acima de 200 já define diabetes, e a HbA1c está falseada por anemia, transfusões e eritropoetina.

C) Hiperglicemia transitória pelo corticoide

Errada. A hiperglicemia transitória é a dos primeiros dias a semanas após o transplante, com corticoide em dose alta; aos 5 meses, com prednisona 5 mg estável, o diagnóstico é de diabetes.

D) Tolerância diminuída à glicose

Errada. A tolerância diminuída tem glicemia de 2 horas entre 140 e 199; valores de 236 e 224 ultrapassam esse limite.

Para levar. No primeiro ano após o transplante a HbA1c subestima a glicemia (anemia, transfusões, eritropoetina): use o teste oral de 75 g para diagnosticar diabetes pós-transplante.

Sharif A et al., Second international consensus on post-transplantation diabetes mellitus, Nephrol Dial Transplant 2024; ADA Standards of Care in Diabetes 2026, seção 2; KDIGO 2009 (Care of the kidney transplant recipient).

---

44 Infectologia · Herpes-zóster oftálmico com sinal de Hutchinson e olho calmo: biomicroscopia antes de qualquer outro exame

Negativo no meio · Gabarito D

Mulher de 68 anos, hipertensa, tem há 2 dias dor em queimação e vesículas agrupadas sobre base eritematosa na fronte e no couro cabeludo à esquerda, sem cruzar a linha média, iniciadas após 3 dias de dor local. Há vesículas também na ponta e na asa do nariz à esquerda. Nega dor ocular, fotofobia ou baixa visual; o olho esquerdo não está hiperemiado à inspeção, e a acuidade visual é 20/25 em ambos. Sem déficit neurológico. Iniciou valaciclovir 1 g de 8/8 horas há 24 horas. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

Há vesículas também na ponta e na asa do nariz à esquerda.

Resolução. O olho calmo, sem dor e com boa acuidade, é um negativo verdadeiro que faz parecer que o zóster ficou na pele, e a tentação é confirmar o vírus por PCR. O diagnóstico de zóster é clínico e já está tratado. O dado que decide é o sinal de Hutchinson: lesões na ponta e na asa do nariz indicam acometimento do ramo nasociliar, que também inerva o globo ocular, e preveem comprometimento ocular (ceratite, uveíte) que pode ser inicialmente oligossintomático. Por isso, a avaliação oftalmológica com biomicroscopia (lâmpada de fenda, com fluoresceína) é o próximo passo, independentemente dos sintomas. RM e punção lombar se reservam para sinais neurológicos (vasculopatia, meningoencefalite), ausentes aqui.

A) PCR de vesícula para VZV ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o diagnóstico de zóster é clínico; PCR seria para lesão atípica ou dúvida diagnóstica.

B) RM de crânio e órbitas

Errada. RM de crânio e órbitas seria para déficit neurológico, oftalmoplegia ou suspeita de vasculopatia pelo VZV.

C) Punção lombar

Errada. Punção lombar seria para suspeita de meningoencefalite, com cefaleia intensa, alteração de consciência ou sinais meníngeos.

D) Biomicroscopia com lâmpada de fenda CORRETA

Correta. Sinal de Hutchinson prevê acometimento ocular: biomicroscopia com lâmpada de fenda mesmo com olho calmo.

Para levar. Zóster oftálmico com vesícula na ponta do nariz (sinal de Hutchinson) exige avaliação oftalmológica com lâmpada de fenda, mesmo sem sintomas oculares.

Cohen JI. Herpes Zoster. N Engl J Med 2013; Liesegang TJ. Herpes zoster ophthalmicus: natural history, risk factors, clinical presentation, and morbidity. Ophthalmology 2008.

---

45 Pneumologia · Doença intersticial por nitrofurantoína profilática rotulada como fibrose pulmonar idiopática

Grade X / Y **Gabarito C**

Mulher de 76 anos tem dispneia progressiva e tosse seca há 8 meses. Há pouco mais de um ano toma, toda noite, um comprimido para não ter mais infecção de urina, receitado pelo urologista. Hipertensa, usa também anlodipino. Nunca fumou; nega aves, mofo, artralgias e Raynaud. Crepitações finas em bases, sem baqueteamento. FAN, fator reumatoide e anti-CCP negativos. ALT 72 U/L. Espirometria: CVF 64% do previsto, VEF1/CVF 0,84; DLCO 51%. TC: opacidades reticulares e em vidro fosco basais e subpleurais, sem faveolamento. A geriatra anterior registrou provável fibrose pulmonar idiopática e sugeriu antifibrótico. A causa mais provável e a primeira conduta são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

toma, toda noite, um comprimido para não ter mais infecção de urina

Resolução. Idosa com doença intersticial basal e subpleural leva ao rótulo de fibrose pulmonar idiopática, mas FPI exige excluir causas conhecidas, e a primeira é droga. A profilaxia noturna de infecção urinária, mantida por mais de um ano, é em geral nitrofurantoína, que causa pneumonite crônica (padrão de pneumonia intersticial não específica ou em organização) após meses de uso, muitas vezes com hepatite associada, como sugere a ALT de 72. Vidro fosco sem faveolamento também não é o padrão de pneumonia intersticial usual. A primeira conduta é suspender a droga, o que costuma melhorar o quadro em semanas a meses; corticoide se reserva a quem não melhora ou tem doença grave, e pulsoterapia não cabe numa paciente estável. Antifibrótico seria erro de diagnóstico.

A) Fibrose pulmonar idiopática / nintedanibe ARMADILHA
Errada. Seria a resposta com padrão de pneumonia intersticial usual (faveolamento) e causas excluídas; a droga em uso ainda não foi afastada.

B) Pneumonia em organização / prednisona oral
Errada. Pneumonia em organização pode ser o padrão histológico da lesão por droga, mas o primeiro passo é retirar a causa, não tratar o padrão.

C) Pneumonite por nitrofurantoína / suspender CORRETA
Correta. Profilaxia urinária crônica com nitrofurantoína, doença intersticial e ALT alta: suspender a droga.

D) Pneumonite por nitrofurantoína / pulsoterapia
Errada. A etiologia está certa, mas pulsoterapia é para insuficiência respiratória aguda grave, que ela não tem.

Para levar. Antes de chamar de FPI, procure droga: nitrofurantoína em profilaxia urinária prolongada causa doença intersticial crônica (e hepatite), e o tratamento é suspender.

ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline on IPF 2022; Pneumotox (pneumotox.com); SBPT, Diretrizes de doenças pulmonares intersticiais 2012.

46

Hematologia · Ferro oral em dias alternados: a hepcidina que sobe após cada dose reduz a absorção da dose seguinte

Cronologia **Gabarito A**

Na reposição de ferro oral para anemia ferropriva sem urgência, administrar a dose em dias alternados, em vez de duas ou três vezes ao dia, aumenta a fração de ferro absorvida porque:

O DADO QUE DECIDE

em vez de duas ou três vezes ao dia

Resolução. A explicação intuitiva é a saturação da transferrina, mas não é ela que regula a absorção intestinal. Cada dose oral de ferro eleva a hepcidina hepática por cerca de 24 horas; a hepcidina se liga à ferroportina, o exportador de ferro do enterócito para o plasma, e provoca sua internalização e degradação. Com a ferroportina reduzida, o ferro da dose seguinte fica retido no enterócito e é perdido com a descamação. Os estudos com isótopos de Stoffel e Moretti mostraram que doses em dias alternados aumentam a fração absorvida e reduzem efeitos gastrointestinais, por isso doses únicas, diárias ou em dias alternados, substituíram as tomadas fracionadas. A hepcidina degrada a ferroportina, e não a induz.

A) A hepcidina sobe por cerca de 24 h após cada dose CORRETA
Correta. A hepcidina induzida por uma dose dura cerca de 24 horas e reduz a ferroportina, diminuindo a absorção da dose seguinte.

B) O DMT1 duodenal é degradado com doses diárias
Errada. O DMT1 é o transportador apical e não é o ponto regulado pela dose oral; a regulação está na ferroportina.

C) A ferroportina é induzida a cada 48 h
Errada. A hepcidina degrada a ferroportina; não existe indução em ciclos de 48 horas.

D) A transferrina satura e bloqueia a absorção ARMADILHA
Errada, é a armadilha. A transferrina transporta o ferro no plasma, mas a absorção é controlada pela hepcidina e pela ferroportina do enterócito.

Para levar. Ferro oral: uma dose eleva a hepcidina por cerca de 24 horas; dose única diária ou em dias alternados absorve melhor que doses fracionadas.

Stoffel et al., Lancet Haematol 2017; Moretti et al., Blood 2015; BSG 2021 Guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults (Snook et al.).

47

Grade X / Y **Gabarito B**

Farmacodermias · Pustulose exantemática generalizada aguda com febre e neutrofilia: suspender a droga e corticoide tópico, sem corticoide sistêmico

Mulher de 49 anos, sem história pessoal ou familiar de psoríase, iniciou azitromicina para sinusite há 2 dias. Há 12 horas surgiu eritema edematoso em face, pescoço, axilas e virilhas, salpicado por dezenas de pústulas puntiformes não foliculares, com ardor, e febre de 38,8 °C. Mucosas poupadas, sem bolhas e sem áreas de destacamento. PA 118 × 72 mmHg, FC 98 bpm. Exames: leucócitos 18.400/mm³ com 14.200 neutrófilos e 600 eosinófilos, PCR 9 mg/dL, creatinina e transaminases normais. Bacterioscopia do conteúdo de uma pústula: neutrófilos, sem bactérias. A azitromicina foi suspensa. O diagnóstico e a conduta são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

iniciou azitromicina para sinusite há 2 dias

Resolução. Pústulas estéreis não foliculares sobre eritema que começa em face e grandes dobras, com febre e neutrofilia, 2 dias após um antibiótico, sem psoríase prévia, é pustulose exantemática generalizada aguda; a latência curta (menos de 48 horas para antibióticos) é característica. A psoríase pustulosa generalizada tem curso mais arrastado, história de psoríase e não guarda relação temporal com a droga. Na conduta está a armadilha: febre de 38,8 °C e 18 mil leucócitos parecem gravidade que pede corticoide sistêmico, mas a doença é autolimitada, as pústulas regridem em 1 a 2 semanas com descamação após a suspensão do fármaco, e o tratamento é corticoide tópico e sintomáticos. Corticoide sistêmico fica para acometimento sistêmico relevante (hepático, renal, respiratório), ausente aqui, e a febre com neutrofilia faz parte do quadro, e não indica antibiótico.

A) Psoríase pustulosa / prednisona oral
Errada nas duas metades: sem psoríase prévia e com latência de 2 dias, e corticoide sistêmico causa rebote na psoríase pustulosa.

B) Pustulose exantemática / corticoide tópico CORRETA
Correta. Pustulose exantemática pela azitromicina, sem órgão acometido: suspender e tratar com corticoide tópico.

C) Pustulose exantemática / prednisona oral ARMADILHA
Errada. O diagnóstico está certo, mas corticoide oral fica para acometimento sistêmico, ausente aqui.

D) Psoríase pustulosa / corticoide tópico
Errada. A conduta seria aceitável, mas o diagnóstico ignora a latência de 2 dias e a ausência de psoríase.

Para levar. Pustulose exantemática generalizada aguda: pústulas estéreis em dobras 1 a 2 dias após antibiótico, com febre e neutrofilia; suspender e usar corticoide tópico.

EuroSCAR AGEP validation score (Sidoroff et al., 2001); AAAAI/ACAAI Drug allergy: a 2022 practice parameter update.

48

Nefrologia · Hipocalcemia sintomática dias após antirreabsortivo subcutâneo semestral na DRC estágio 4 · denosumabe, e não só a vitamina D baixa

Droga a deduzir | Gabarito A

Mulher de 79 anos, com doença renal crônica (TFGe de 21 mL/min/1,73 m²) e osteoporose com fratura vertebral, recebeu há 12 dias a primeira dose da medicação antirreabsortiva subcutânea de aplicação semestral, escolhida porque o bisfosfonato estava contraindicado pela função renal. Hoje refere parestesias periorais e cãibras. Sinal

de Chvostek presente. Exames: cálcio total de 6,9 mg/dL com albumina de 3,9 g/dL, fósforo 4,1 mg/dL, magnésio 2,0 mg/dL, PTH 390 pg/mL, 25-hidroxivitamina D de 16 ng/mL; o cálcio era de 9,0 mg/dL há 1 mês, com os demais exames semelhantes. QTc de 500 ms. A causa principal da hipocalcemia é:

O DADO QUE DECIDE

o cálcio era de 9,0 mg/dL há 1 mês, com os demais exames semelhantes

Resolução. A 25-hidroxivitamina D de 16 ng/mL é o rótulo verdadeiro: ela está baixa e é causa conhecida de hipocalcemia. Mas a deficiência já existia há 1 mês com cálcio de 9,0, e o que mudou nesse intervalo foi a droga a deduzir: antirreabsortivo subcutâneo semestral é o denosumabe, escolhido justamente porque não depende de depuração renal. Ao bloquear o RANKL, ele interrompe a liberação de cálcio do osso, e na DRC avançada, em que o hiperparatireoidismo secundário mantém o cálcio à custa de alta remodelação óssea, a queda é abrupta, com nadir em 1 a 3 semanas e hipocalcemia grave em uma fração relevante desses pacientes. O PTH alto afasta hipoparatireoidismo, e o fósforo de 4,1 não explica a queda. A lição é corrigir a vitamina D e o cálcio antes da dose e dosar o cálcio na 1ª e 2ª semanas em quem tem TFG abaixo de 30.

A) Ação do denosumabe CORRETA
Correta. A queda do cálcio coincide com a primeira dose de denosumabe, cujo efeito é máximo na DRC avançada com alta remodelação.

B) Deficiência de vitamina D ARMADILHA
Errada. Contribui e devia ter sido corrigida antes da dose, mas já existia com cálcio de 9,0 há 1 mês; não explica a queda recente.

C) Hipoparatireoidismo
Errada. O hipoparatireoidismo teria PTH baixo ou inapropriadamente normal; o PTH de 390 pg/mL é a resposta adequada à hipocalcemia.

D) Hiperfosfatemia da DRC
Errada. Seria considerada com fósforo muito alto (acima de 7 a 8 mg/dL); 4,1 mg/dL não explica a queda.

Para levar. Denosumabe na DRC avançada causa hipocalcemia grave em 1 a 3 semanas: corrigir vitamina D e cálcio antes da dose e dosar o cálcio nas primeiras semanas.

FDA Boxed Warning: severe hypocalcemia with denosumab in advanced CKD (2024); KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for CKD-MBD; Radominski SC et al. Diretrizes brasileiras para o diagnóstico e tratamento da osteoporose em mulheres na pós-menopausa. Rev Bras Reumatol 2017.

---

49 Oncologia · Câncer de cólon metastático antes do anti-EGFR: pesquisa de RAS, BRAF e reparo de DNA no tumor

Dado omitido **Gabarito D**

Homem de 58 anos, com adenocarcinoma de cólon sigmoide diagnosticado por colonoscopia, tem na TC múltiplas metástases hepáticas bilobares, consideradas irressecáveis pela equipe de cirurgia hepática, sem doença extra-hepática. ECOG 1, função hepática e renal normais, CEA de 84 ng/mL. A oncologista considera iniciar quimioterapia com FOLFOX associada a anticorpo monoclonal anti-EGFR, pela localização à esquerda do tumor primário. A biópsia da lesão primária só tem o diagnóstico histológico. Antes de definir o esquema, o próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

A biópsia da lesão primária só tem o diagnóstico histológico

Resolução. Se a droga é anti-EGFR, parece lógico medir o EGFR no tumor, e é a armadilha. Mas a expressão de EGFR por imuno-histoquímica não prediz resposta. O que prediz é o estado de RAS: mutações de KRAS ou NRAS (éxons 2, 3 e 4) tornam o anti-EGFR ineficaz e até prejudicial, e ele só se usa em RAS selvagem, preferencialmente de cólon esquerdo. O BRAF V600E muda prognóstico e linha de tratamento (encorafenibe com cetuximabe), e a deficiência de reparo (ou instabilidade de microssatélites) indica imunoterapia em primeira linha, que supera a quimioterapia. O caso omite exatamente esse perfil molecular, e é ele que define o esquema. PET-CT e marcadores seriados não escolhem droga.

A) Imuno-histoquímica para expressão de EGFR ARMADILHA
Errada. Parece a medida natural antes do anti-EGFR, mas a expressão de EGFR não prediz resposta; o que importa é o RAS.

B) PET-CT com FDG de corpo inteiro
Errada. Teria papel para excluir doença extra-hepática antes de ressecção com intenção curativa; não define o esquema sistêmico.

C) CEA e CA 19-9 seriados por 4 semanas
Errada. Marcadores servem a seguimento de resposta, e não à escolha da terapia.

D) Pesquisa de RAS, BRAF e reparo de DNA no tumor CORRETA
Correta. RAS mutado contraindica anti-EGFR, BRAF muda a linha e deficiência de reparo indica imunoterapia de primeira linha.

Para levar. Câncer colorretal metastático: RAS, BRAF e reparo de DNA (MMR ou MSI) antes da primeira linha; anti-EGFR só em RAS selvagem, e dMMR vai para imunoterapia.

ESMO Clinical Practice Guideline: Metastatic colorectal cancer (2023); NCCN Colon Cancer (2025); ASCO Guideline: Treatment of Metastatic Colorectal Cancer (2023)

---

50 Neurologia · Tremor essencial na asma: primidona como primeira escolha oral

Qualificador **Gabarito C**

Em paciente com tremor essencial que limita a escrita e o uso de talheres, e que tem asma persistente em uso de budesonida-formoterol, o tratamento oral de primeira escolha é:

O DADO QUE DECIDE

asma persistente em uso de budesonida-formoterol

Resolução. Propranolol e primidona são as duas drogas de primeira linha no tremor essencial, com eficácia semelhante (redução de cerca de 50% da amplitude). O qualificador decide: na asma o betabloqueador não seletivo pode desencadear broncoespasmo grave e é contraindicado. Sobra a primidona, iniciada em dose baixa (12,5 a 25 mg à noite) pela sedação e náusea das primeiras doses. Benzodiazepínicos e topiramato são segunda linha, e levodopa não age no tremor essencial.

A) Propranolol ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a primeira escolha sem asma; betabloqueador não seletivo na asma persistente arrisca broncoespasmo.

B) Clonazepam

Errada. Clonazepam é segunda linha, com eficácia menor e risco de dependência e quedas.

C) Primidona CORRETA

Correta. Primeira linha ao lado do propranolol, e a escolha quando o betabloqueador é contraindicado.

D) Levodopa

Errada. Levodopa trata o tremor de repouso da doença de Parkinson, não o tremor de ação do tremor essencial.

Para levar. Tremor essencial: propranolol ou primidona; com asma, primidona.

AAN Evidence-based guideline update: treatment of essential tremor 2011 (reafirmada); MDS Evidence-Based Medicine Review on treatments for essential tremor (Ferreira et al., Mov Disord 2019); GINA 2024 (betabloqueador não seletivo na asma).